



PPGPSICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL



Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituto de Psicologia, Serviço Social, Saúde e Comunicação Humana

Programa de Pós-Graduação em Psicologia

COMPETÊNCIAS MULTICULTURAIS E PRÁTICA CLÍNICA PSICOLÓGICA:
CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E ADAPTAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE
AVALIAÇÃO

Ellen Dias Romero

Dissertação de Mestrado

Porto Alegre

2026

COMPETÊNCIAS MULTICULTURAIS E PRÁTICA CLÍNICA PSICOLÓGICA:
CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E ADAPTAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE
AVALIAÇÃO

Ellen Dias Romero

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Psicologia.

Orientadora: Prof. Dra. Letícia Sanguinetti Czepielewski e
coorientação do Prof. Dr. Evandro Morais Peixoto

Porto Alegre

2026

Sumário

LISTA DE TABELAS.....	4
LISTA DE FIGURAS.....	5
RESUMO.....	6
ABSTRACT.....	7
APRESENTAÇÃO.....	8
Capítulo I: Fundamentação Teórica.....	10
Do racismo científico à raça como construção social.....	10
Brasil Pós-Abolição e o Mito da Democracia Racial.....	12
As dimensões do racismo.....	14
A Psicologia enquanto ciência e profissão implicada ao racismo.....	17
Psicologia enquanto ciência: sujeito de referência e apagamento das experiências racializadas.....	17
Quem faz a psicologia no Brasil? O que diz o CensoPsi.....	19
Efeitos do racismo na saúde mental.....	20
Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI).....	26
Objetivos.....	28
Capítulo II: Artigo.....	29
Adaptação transcultural da versão brasileira do Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI-BR).....	29
Resumo.....	29
Abstract.....	30
Método.....	33
Resultados.....	35
Discussão.....	37
Capítulo III: Evidências psicométricas preliminares e desafios na pesquisa.....	40
Método.....	40
Resultados.....	42
Discussão.....	44
Considerações finais.....	47
Referências.....	48
ANEXOS.....	57
ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA.....	58
ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.....	62
ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE).....	63
ANEXO D – FORMULÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO.....	66
ANEXO E – CULTURAL COMPETENCE ASSESSMENT INSTRUMENT – VERSÃO BRASILEIRA (CCAI-BR).....	70

ANEXO F - ESCALA DE EFICÁCIA ANTIRRACISTA.....	76
ANEXO G – ESCALA DE CONSCIÊNCIA CRÍTICA (ECC-36).....	78
ANEXO H – INSTRUMENTO ORIGINAL.....	81

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Integração entre a Teoria do Estresse de Minorias e a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano.....	23
Tabela 2 – Itens avaliativos do CCAI-BR.....	36

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Dimensões do racismo.....	16
--------------------------------------	----

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo realizar a adaptação transcultural e a produção de evidências psicométricas preliminares de validade do Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) para o contexto brasileiro, considerando sua aplicabilidade à prática clínica psicológica. O estudo foi desenvolvido em duas etapas. A primeira consistiu na tradução e adaptação transcultural do instrumento, seguindo diretrizes internacionais para adaptação de medidas psicológicas, incluindo tradução independente, retrotradução, avaliação por comitê de especialistas e grupos focais com psicólogos clínicos, resultando na versão brasileira do instrumento (CCAI-BR). A segunda etapa correspondeu à aplicação do CCAI-BR em uma amostra inicial de 112 psicólogos brasileiros, com o objetivo de explorar evidências psicométricas preliminares e padrões de resposta relacionados às competências multiculturais. Foram realizadas análises descritivas e exploratórias dos dados, considerando as limitações decorrentes do tamanho amostral, que inviabilizaram análises mais robustas de consistência interna e estrutura fatorial. Os resultados indicaram adequada compreensão dos itens, boa aceitabilidade do instrumento e padrões de resposta coerentes com pressupostos teóricos das competências multiculturais na prática clínica. As análises exploratórias também sugerem associações relevantes entre competências multiculturais, experiências formativas e características profissionais dos participantes. Conclui-se que o CCAI-BR apresenta potencial como instrumento de avaliação e autorreflexão para psicólogos, contribuindo para o aprimoramento de práticas clínicas culturalmente sensíveis e para o desenvolvimento de uma Psicologia comprometida com a equidade no cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Competências multiculturais; Psicologia clínica; Avaliação psicológica; Racismo; Saúde mental.

ABSTRACT

This dissertation aimed to conduct the cross-cultural adaptation and to produce preliminary psychometric validity evidence of the Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) for the Brazilian context, considering its applicability to clinical psychological practice. The study was developed in two stages. The first stage involved the translation and cross-cultural adaptation of the instrument, following international guidelines for psychological test adaptation, including independent translation, back-translation, evaluation by an expert committee, and focus groups with clinical psychologists, resulting in the Brazilian version of the instrument (CCAI-BR). The second stage consisted of the application of the CCAI-BR to an initial sample of 112 Brazilian psychologists, aiming to explore preliminary psychometric evidence and response patterns related to multicultural competencies. Descriptive and exploratory analyses were conducted, taking into account limitations related to sample size, which precluded more robust analyses of internal consistency and factor structure. The results indicated adequate item comprehension, good acceptability of the instrument, and response patterns consistent with theoretical assumptions of multicultural competencies in clinical practice. Exploratory analyses also suggested relevant associations between multicultural competencies, professional training experiences, and participants' professional characteristics. It is concluded that the CCAI-BR shows potential as an assessment and self-reflection tool for psychologists, contributing to the improvement of culturally sensitive clinical practices and to the development of Psychology committed to equity in mental health care.

Keywords: Multicultural competencies; Clinical psychology; Psychological assessment; Racism; Mental health

APRESENTAÇÃO

A literatura contemporânea em saúde mental tem demonstrado que minorias sociais enfrentam disparidades sistemáticas no acesso à qualidade do cuidado, apresentando, frequentemente, piores desfechos de saúde (Page et al., 2024). Ao olharmos para a população negra brasileira, esse cenário é agravado por um histórico de negligência institucional, cujas demandas psíquicas são atravessadas por traumas de racialização que a Psicologia tradicional, pautada em um “sujeito universal” branco e eurocêntrico, falhou em acolher (Queiroz & Araújo, 2024).

Diante dessa realidade, o exercício da Psicologia não pode ser dissociado de um compromisso político e social. O Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) estabelece como princípio fundamental a promoção da saúde e a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação e opressão. Para que esse imperativo ético se materialize na prática clínica, é imprescindível que o profissional desenvolva Competências Multiculturais (CM). As CMs são compreendidas como um conjunto de conhecimentos e habilidades que permitem ao terapeuta reconhecer e incorporar a dimensão cultural do cliente no processo psicoterapêutico, sendo um preditor de uma aliança terapêutica fortalecida e resultados clínicos mais eficazes (Farias et al., 2024; Teixeira et al., 2025).

Entretanto, o desenvolvimento dessas competências encontra barreiras em uma formação acadêmica que ainda transversaliza pouco as relações étnico-raciais (Lima et al., 2021) e na ausência de instrumentos nacionais que auxiliem o profissional de saúde a avaliar suas competências (Ronzani et al., 2025). Diante disso, este estudo objetiva a adaptação transcultural e a produção de evidências de validade do Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) para o contexto brasileiro. Para isso, dividimos o estudo em duas etapas sendo a primeira constituída na tradução e adaptação do instrumento e a segunda etapa na produção de evidências de validade.

Para que você, leitor, tenha uma melhor experiência e compreensão do percurso percorrido nesta pesquisa, a dissertação foi organizada em três capítulos:

No capítulo I, apresenta-se a fundamentação teórica, que contextualiza os processos históricos que possibilitaram a escravização de corpos negros, as repercussões do período pós-abolição para a população negra e os impactos dessas experiências na saúde mental, bem como bases teóricas que permitem compreender como o racismo atua em diferentes níveis, as consequências disso para o fazer psicológico e finaliza apresentando as competências multiculturais como uma postura metodológica fundamental para a prática clínica.

O capítulo II corresponde à primeira etapa da pesquisa e apresenta, em formato de artigo científico, o processo de tradução e adaptação transcultural do CCAI para o contexto brasileiro culminando no CCAI-BR. Este capítulo descreve de forma detalhada os procedimentos metodológicos adotados, encerrando-se antes da etapa de produção de evidências psicométricas de validade.

Por fim, o capítulo III apresenta a segunda etapa da pesquisa, referente à produção de evidências psicométricas de validade da versão brasileira do instrumento, etapa que se encontra em andamento no momento da redação deste trabalho. São descritos os procedimentos de coleta e análises dos dados obtidos até o momento, a partir da aplicação do CCAI-BR em uma amostra inicial de 112 profissionais da psicologia. O texto é finalizado com algumas considerações sobre os desafios da pesquisa e apontamentos sobre o fortalecimento de uma Psicologia antirracista.

Capítulo I: Fundamentação Teórica

Do racismo científico à raça como construção social

O racismo pode ser compreendido como um sistema de dominação que hierarquiza grupos humanos a partir da crença na existência de raças superiores, produzindo privilégios para determinados grupos (Almeida, 2019). Embora parte da literatura atual argumente que o fenômeno emerge como produto da reprodução do capitalismo, Batista e Mastrodi (2018) afirmam que o racismo deve ser entendido como um fenômeno extraeconômico que antecede o capitalismo e lhe dá sustentação. As autoras argumentam que antes mesmo da consolidação do modo de produção capitalista já estavam em circulação discursos morais, religiosos e filosóficos que separaram a humanidade em degraus, definindo quem seria reconhecido como inteiramente humano e quem poderia ser dominado, explorado ou violentado.

Essas concepções ofereceram a base simbólica que tornou possível a colonização e escravização como processos moralmente legitimados (Batista & Mastrodi, 2018; Cunha et al., 2024). A distinção entre “civilizados” e “selvagens” operou como uma tecnologia central do colonialismo europeu, sustentando a supremacia branca e autorizando a expropriação de territórios, a violência extrema e a exploração sistemática de povos africanos e indígenas (Cunha et al., 2024).

Inicialmente, tais hierarquizações foram sustentadas por narrativas religiosas, como o Mito de Cam. Hardtke e González (2025) explicam que, este mito, associou os descendentes de Cam ao continente africano e à população negra fazendo com que a cor da pele fosse interpretada como sinal visível de uma suposta maldição divina, vinculada à degeneração moral e espiritual. Nesse contexto, a servidão passou a ser compreendida como forma de correção e salvação.

A partir dessas construções, a população negra passou a ser vista como inferior, frequentemente associada à animalidade, à ausência de racionalidade e à incapacidade moral, sendo posicionada em degraus inferiores da hierarquia humana (Junior, 2021). Com o avanço da modernidade, essas justificativas religiosas foram progressivamente ressignificadas e incorporadas ao discurso científico, originando o que chamamos de racismo científico (dos Santos & Silva, 2018; de Souza, 2022).

No século XIX, sob influência do darwinismo social, teorias raciais passaram a atribuir à biologia a existência de raças humanas distintas, concebidas como naturalmente desiguais (dos Santos & Silva, 2018; da Silva et al., 2023). Características fenotípicas como a cor da pele, o formato do nariz, o tipo de cabelo e outros traços físicos e comportamentais passaram a ser mobilizadas como marcadores de uma possível tendência natural ao crime e à loucura (Mota, 2021). A partir dessas características, métodos como a craniometria e a antropometria foram utilizados para medir, classificar e comparar corpos, buscando correlacionar tais traços a diferenças intelectuais e morais. Essas práticas científicas interpretavam variações corporais como evidências de menor inteligência e humanidade, contribuindo para a naturalização da exploração e para a redução dos corpos negros à condição de mercadoria ou força de trabalho (da Silva et al., 2023; dos Santos & Silva, 2018; Junior, 2021)

Com os avanços científicos do século XX, especialmente no campo da genética, essas premissas biológicas foram progressivamente refutadas, demonstrando que não existem raças humanas do ponto de vista biológico (Almeida, 2019; da Silva et al., 2023). No entanto, a refutação científica da raça não implicou no desaparecimento do racismo, uma vez que este não se sustentava exclusivamente em argumentos biológicos, mas também em processos históricos e sociais que associaram características fenotípicas a valores morais, intelectuais e sociais (Almeida, 2019; Cunha et al., 2024).

Dessa forma, o conceito de raça permanece sendo utilizado como uma categoria analítica fundamental para a compreensão das desigualdades raciais, uma vez que descreve uma realidade concreta de discriminação, exclusão e distribuição desigual de oportunidades, como observado no contexto brasileiro (Almeida, 2019; Cunha et al., 2024).

Brasil Pós-Abolição e o Mito da Democracia Racial

A escravização no Brasil constituiu-se como um sistema de longa duração, sustentado por mais de três séculos por meio do tráfico transatlântico de africanos, da exploração intensiva do trabalho e da desumanização sistemática dos corpos negros (Aiquoc et al., 2021; dos Santos & Silva, 2018). Esse processo estruturou a economia colonial e as hierarquias sociais e raciais que organizaram a sociedade brasileira desde o período colonial (dos Santos & Silva, 2018; Zamora, 2012).

Apesar disso, é muito importante ressaltar que esse sistema não se estabeleceu sem enfrentamento. Ao longo de todo o período escravista, a população negra construiu contínuas estratégias de resistência à dominação, expressas em fugas, formação de quilombos, preservação de práticas culturais e religiosas e formas próprias de organização coletiva (Aiquoc et al., 2021; dos Santos & Silva, 2018).

A partir do século XIX, com a expansão do capitalismo, novas formas de organização de trabalho baseadas na ampliação do mercado consumidor e na reorganização das economias nacionais eram demandadas. Nesse contexto, intensificaram-se as pressões internacionais - especialmente da Inglaterra - pelo fim do regime escravista, vinculadas a interesses econômicos e geopolíticos, e não ao reconhecimento da humanidade da população negra. A abolição da escravização no Brasil, nesse sentido, ocorreu de forma tardia e coercitiva, fazendo com que o país se tornasse o último do Ocidente a extinguir formalmente esse regime (Batista & Mastrodi, 2018; Junior, 2021).

O pós-abolição brasileiro foi marcado pela ausência de políticas de reparação voltadas à inclusão social, econômica e política da população negra recém-liberta (Cunha et al., 2024). O Estado se reorganizou mantendo as hierarquias raciais construídas ao longo do período escravocrata, colocando a população negra em condições de marginalização social, precarização do trabalho e exclusão do acesso à terra, à educação e à cidadania plena (Cunha et al., 2024; dos Santos & Silva, 2018; Zamora, 2012). A liberdade não se traduziu em condições materiais de existência, consolidando um cenário no qual as desigualdades raciais foram naturalizadas e transmitidas entre gerações (Almeida, 2019). Ainda assim, é importante destacar que o pós-abolição também foi marcado pela reorganização do movimento negro, com a criação de associações, imprensa negra e outras formas de mobilização política em disputa por direitos e reconhecimento (Junior, 2021).

Paralelamente a esse cenário, consolidava-se no país a política nacional de embranquecimento, sustentada pelo racismo científico e pelo movimento eugenista brasileiro, que defendiam a superioridade racial branca e orientavam políticas estatais de imigração e organização social (Filho & Silva, 2024). A imigração europeia foi incentivada como estratégia de modernização nacional e reorganização demográfica, partindo da premissa de que a miscigenação progressiva levaria ao apagamento da população negra enquanto grupo social (Filho & Silva, 2024; dos Santos & Silva, 2018).

Apesar de seu alcance, o branqueamento não eliminou a presença negra nem solucionou as desigualdades produzidas pela escravização. Diante da permanência dessas tensões raciais, as elites brasileiras passaram a produzir um discurso nacional capaz de mascarar conflitos e projetar a imagem de um país integrado e harmonioso racialmente (Junior, 2021). É nesse contexto que se consolida o mito da democracia racial, amplamente difundido a partir das interpretações de Gilberto Freyre, que passaram a valorizar a

miscigenação como traço positivo da formação social brasileira e a sustentar a ideia de convivência racial pacífica (Domingues, 2005).

O mito da democracia racial operou como um dispositivo que dificultou o reconhecimento das desigualdades raciais como produto de um sistema histórico de dominação. Ao negar a centralidade do racismo, esse discurso enfraquece a demanda por políticas de reparação e contribui para a naturalização das desigualdades sociais, já que não se combate o que não existe (Almeida, 2019; Domingues, 2005). Diferentemente de contextos marcados por sistemas explícitos de segregação legal, como os Estados Unidos ou a África do Sul, no Brasil o racismo passou a operar de forma velada, sustentado pela negação e pela informalidade das práticas discriminatórias (Almeida, 2019; Zamora, 2012).

Entretanto, os indicadores sociais e de saúde desmentem essa narrativa. A população negra, que atualmente representa cerca de 55% da população brasileira (IBGE, 2022) permanece desproporcionalmente exposta a condições de vulnerabilidade social, com piores indicadores de renda, escolaridade, acesso a serviços públicos e condições de vida quando comparada à população branca (Brasil. Ministério da Saúde, 2017; Estrela et al., 2021; Galvão et al., 2021). Esses dados demonstram que o racismo persiste e se retroalimenta ao longo do tempo, fazendo com que a sua negação dificulte seu enfrentamento, ao mesmo tempo que as próprias desigualdades sustentam a sua manutenção até os dias de hoje.

Para compreendermos como esse sistema se mantém ativo no cotidiano e nas instituições, torna-se necessário analisar os mecanismos por meio dos quais o racismo se estrutura e se reproduz em diferentes níveis, questão que será aprofundada a seguir.

As dimensões do racismo

A compreensão histórica do racismo apresentada nos tópicos anteriores evidencia que esse fenômeno se constitui em um sistema social que se atualiza constantemente nas instituições, nas relações interpessoais e na subjetividade. Para compreender como esse

sistema opera, Jones (2002) propõe um modelo analítico que descreve o racismo em três dimensões interligadas: institucional, interpessoal e internalizado. Essas dimensões atuam de forma simultânea e articulada, produzindo e mantendo desigualdades ao longo do tempo (Werneck, 2016).

Conforme ilustrado na Figura 1, o racismo institucional refere-se às estruturas, políticas e práticas de instituições sociais que resultam em desigualdade sistemática no acesso a direitos, bens e oportunidades, independentemente da intenção individual dos agentes envolvidos. No contexto brasileiro, essa dimensão se manifesta, por exemplo, nas desigualdades persistentes no acesso à saúde, educação e justiça, produzindo condições de vulnerabilização que atingem de forma desproporcional a população negra (Werneck, 2016).

O racismo interpessoal diz respeito às experiências cotidianas de preconceito e discriminação nas interações sociais. Essas manifestações podem ocorrer de forma explícita ou sutil, incluindo práticas de desrespeito, vigilância excessiva e desqualificação (Zamora, 2012). No Brasil, esse tipo de racismo tende a operar de forma velada, dificultando sua nomeação e reconhecimento, o que contribui para a naturalização da violência racial e para a produção de sofrimento psíquico contínuo (Jones, 2002; Zamora, 2012).

Por fim, o racismo internalizado refere-se à incorporação, por pessoas negras, de mensagens sociais negativas associadas à sua raça, ao seu corpo e às suas capacidades. Trata-se de um processo socialmente produzido, no qual a violência simbólica do racismo é introjetada, afetando a construção da identidade, da autoestima e do senso de pertencimento. Essa dimensão se expressa, por exemplo, na valorização da branquitude como ideal normativo, na rejeição de traços fenotípicos negros e na autovigilância constante (Jones, 2002).

A ausência de políticas públicas eficazes é, ao mesmo tempo, uma consequência e um motor desse sistema. Werneck (2016) ressalta que, sem ações intencionais para desconstruir

essas desigualdades, o racismo institucional permanece operante, especialmente em áreas como a saúde e a educação, nas quais a população negra enfrenta barreiras estruturais ao acesso a direitos básicos. Essa omissão reflete escolhas políticas que ignoram demandas históricas por reparação e equidade, perpetuando a lógica excludente que caracteriza o racismo estrutural.

Figura 1

Dimensões do racismo



Nota. Extraído de "Racismo institucional e saúde da população negra", por Werneck, 2016, Saúde e Sociedade, 25(3), p. 540

A partir dessa lógica, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), elaborada pelo Ministério da Saúde (2017), surge como um marco na tentativa de enfrentamento das iniquidades de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). Reconhecendo o racismo como um determinante social que agrava as desigualdades e aumenta a morbimortalidade da população negra, a política propõe estratégias específicas para a promoção da equidade. No campo da saúde mental, a PNSIPN destaca a necessidade de qualificar o cuidado prestado a crianças, jovens, adultos e idosos negros, considerando as especificidades e vulnerabilidades desse grupo. Entre suas prioridades, incluem-se a

prevenção de agravos decorrentes da discriminação racial e da exclusão social e a atenção especializada à saúde de pessoas negras. Ao integrar o combate ao racismo às práticas de cuidado, a política reafirma a importância de ações que reconheçam o impacto cumulativo da discriminação e promovam maior inclusão nos serviços de saúde.

Nesse sentido, torna-se fundamental questionar o papel das instituições responsáveis pela produção de saber e pelo cuidado em saúde mental. A Psicologia, enquanto ciência e profissão historicamente constituída em um contexto embranquecido, não está alheia a esses processos. Discutiremos, a seguir, de que modo a Psicologia tem contribuído para a manutenção dessas desigualdades e para as falhas no cuidado em saúde mental destinado à população negra.

A Psicologia enquanto ciência e profissão implicada ao racismo

Psicologia enquanto ciência: sujeito de referência e apagamento das experiências racializadas

A Psicologia constituiu-se historicamente nos países centrais do Ocidente, tomando como referência um modelo específico de sujeito - homem, branco, cisgênero, heterossexual e de classe média - que passou a orientar a definição de normalidade, saúde e adoecimento psíquico (Furini et al., 2023; Teixeira et al., 2025). Esse sujeito, apresentado como universal, constitui-se a partir de uma matriz branca e europeia de humanidade e conhecimento, o que contribui para o apagamento sistemático de sujeitos racializados e para a naturalização da branquitude como norma implícita nos regimes de saber e poder, inclusive no campo psicológico (Kilomba, 2019).

Historicamente, a Psicologia não reconhecia o racismo como determinante da saúde mental, favorecendo leituras individualizantes em vez de sociais e raciais (Zamora, 2012). Nesse contexto, as vivências da população negra foram frequentemente desconsideradas nos modelos explicativos de saúde e adoecimento ou interpretadas como desvios em relação a um

padrão normativo branco, o que contribuiu para práticas patologizantes e descontextualizadas (Lima et al., 2021).

Essa lógica atravessou (e ainda atravessa) os processos formativos em saúde, incluindo a Psicologia. Os currículos de graduação historicamente negligenciaram o debate sobre raça e racismo, tratando-o, quando presente, como tema periférico, optativo ou desvinculado das práticas clínicas e institucionais (Lima et al., 2021). Kilomba (2019) aponta que saberes produzidos a partir de experiências negras são frequentemente deslegitimados, enquanto a produção branca é tomada como referência universal de conhecimento científico. Assim, a forma como a Psicologia se constituiu enquanto ciência impacta diretamente o que se ensina, o que se pesquisa e o que se reconhece como sofrimento legítimo.

A ausência desses debates nos espaços acadêmicos compromete a capacidade dos profissionais de compreender as demandas da população negra de forma contextualizada (Estrela et al., 2021), além de contribuir para a falta de produção científica voltada a essa população. Embora se observe um crescimento recente de pesquisas sobre racismo e saúde mental, essa produção ainda é tardia e insuficiente frente à magnitude das desigualdades raciais, refletindo o atraso histórico da Psicologia em incorporar a raça como eixo central de análise (Damasceno & Zanello, 2018; Nascimento & Silva, 2021).

Como consequência desse percurso formativo, psicólogos e psicólogas são frequentemente formados sem o aporte teórico e prático necessário para reconhecer o racismo como elemento estruturante do sofrimento psíquico. Essa lacuna pode resultar em intervenções iatrogênicas (Tavares & Trad, 2021) e em falhas éticas no exercício profissional. O Código de Ética Profissional do Psicólogo (CFP, 2005) estabelece como princípio fundamental a promoção da dignidade humana e o enfrentamento de quaisquer formas de discriminação, negligência ou opressão. Nesse sentido, a omissão ou a suposta neutralidade frente ao racismo não apenas contribui para a manutenção do *status quo* das desigualdades

raciais, como também configura uma falha ética, ao legitimar modos de cuidado que perpetuam o sofrimento psíquico de populações historicamente racializadas, ainda que de forma não intencional (Juvenil et al., 2023).

Quem faz a psicologia no Brasil? O que diz o CensoPsi

Os dados do Censo da Psicologia Brasileira, realizado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) em 2021, com a participação de mais de 20 mil profissionais de todas as regiões do país, permitem traçar um retrato detalhado do perfil sociodemográfico da profissão e evidenciar as desigualdades que a atravessam (CFP, 2022).

No que se refere ao gênero, a Psicologia permanece sendo uma profissão majoritariamente feminina. De acordo com o Censo, 79% dos profissionais se identificam como do gênero feminino, 20% como do gênero masculino e 0,7% como de identidades não-binárias. Apesar dessa predominância feminina, os dados de renda indicam que os homens ocupam, de forma desproporcional, as faixas de maior rendimento, revelando a persistência de desigualdades de gênero mesmo em uma profissão composta majoritariamente por mulheres (CFP, 2022).

Em relação à orientação sexual, o levantamento aponta que 84% dos profissionais se autodeclararam heterossexuais, enquanto 8% se identificam como homossexuais, 8% como bissexuais ou pansexuais e aproximadamente 0,3% como assexuais. Quando esses marcadores são analisados em conjunto com a renda, observa-se que profissionais não heterossexuais apresentam remuneração média inferior, correspondendo a cerca de 74% da renda média de profissionais heterossexuais, o que evidencia a interseção entre sexualidade e desigualdade econômica na profissão (CFP, 2022).

No que diz respeito à raça/cor, os dados demonstram uma forte assimetria racial na composição da Psicologia brasileira. 64% da amostra se autodeclarou branca, 26% parda,

enquanto a presença de pessoas pretas, indígenas e amarelas é significativamente menor, 8, 1 e 0,4% respectivamente.

As desigualdades tornam-se ainda mais explícitas quando se analisam os indicadores de renda a partir da raça. Psicólogas(os) brancas(os) apresentam renda média mensal superior à de psicólogas(os) não brancas(os). Os dados indicam que a renda média de profissionais não brancas(os) corresponde a aproximadamente 71% da renda média de profissionais brancas(os). Quando se observam especificamente as médias salariais, pessoas pretas apresentam uma das menores rendas médias da profissão, em torno de R\$ 2.280, enquanto pessoas brancas apresentam renda média superior, em torno de R\$ 3.368, e pessoas amarelas alcançam médias ainda mais elevadas (CFP, 2022).

Além disso, a distribuição das faixas salariais evidencia que profissionais brancas(os) concentram-se com maior frequência nas faixas de 5 a 10 salários mínimos, enquanto profissionais pretas(os) e pardas(os) estão majoritariamente concentradas(os) nas faixas de 1 a 3 salários mínimos, indicando uma hierarquização racial interna à profissão (CFP, 2022).

Esses dados demonstram que a Psicologia, enquanto ciência e profissão, não apenas atua em uma sociedade marcada pelo racismo estrutural, mas também reproduz internamente essas desigualdades. A sub-representação de pessoas negras, aliada à concentração racial e de gênero nas faixas de maior renda, evidencia que o acesso à formação, à permanência e às posições de maior prestígio na Psicologia permanece racializado. Esse cenário contribui para a manutenção de práticas de cuidado que, muitas vezes, não reconhecem o racismo como determinante central do sofrimento psíquico, reforçando a necessidade de uma Psicologia eticamente comprometida com a equidade racial

Efeitos do racismo na saúde mental

A saúde mental se constitui a partir da interação complexa entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, resultantes de um equilíbrio dinâmico nas interações do indivíduo com

o meio e com outras pessoas (Alves & Lucena, 2021). No caso da população negra, essas interações ocorrem em um contexto marcado pela exposição contínua ao racismo, o que faz com que o sofrimento psíquico não possa ser compreendido de forma dissociada das desigualdades raciais historicamente produzidas (da Silva, 2021; Tavares & Trad, 2021; Zamora, 2012).

A literatura vem indicando que a população negra apresenta piores desfechos em saúde mental quando comparada à população branca demonstrando maior prevalência de transtornos mentais comuns, especialmente sintomas depressivos e ansiosos, bem como maior sofrimento psicológico associado à discriminação racial, à precarização das condições de vida e à violência institucional (Damasceno & Zanello, 2018; Faro & Pereira, 2011; Martins, 2023; Nascimento & Silva, 2021; Pantoja et al., 2019).

Além disso, adolescentes e jovens negros apresentam risco significativamente maior de ideação suicida e de morte por suicídio quando comparado a seus pares brancos revelando os impactos do racismo sobre a saúde mental se manifestam de forma precoce e se intensificam ao longo do desenvolvimento (Alves & Lucena, 2021; da Silva, 2021; Martins, 2023) demonstrando como o sofrimento psíquico associado ao racismo atravessa todo o curso de vida.

Esses desfechos são considerados uma combinação de fatores psicossociais, entre os quais se destacam a exposição recorrente a experiências de discriminação racial, a desvalorização social, a exclusão simbólica, a violência institucional e os lutos repetidos decorrentes do genocídio da população negra (Damasceno & Zanello, 2018; Martins, 2023; Pantoja et al., 2019; Silva, 2021). A vivência reiterada de humilhação, suspeição constante e barreiras no acesso a direitos e bens contribui para o desenvolvimento de quadros de depressão, ansiedade e sintomas compatíveis com os transtornos relacionados ao trauma, incluindo o trauma racial (Holmes et al., 2024; Mata & Pelisoli, 2016; Silva, 2021).

Além disso, a exposição prolongada a experiências de racismo contribui para o desenvolvimento de estresse crônico, caracterizado por hipervigilância, fadiga emocional, irritabilidade, dificuldades de regulação emocional e sintomas psicossomáticos, como dores crônicas e alterações do sono (Faro & Pereira, 2011). Esse estresse contínuo nos ajuda a explicar o adoecimento psíquico da população negra, mesmo na ausência de eventos traumáticos isolados.

Nesse sentido, a Teoria do Estresse de Minorias (TEM), formulada por Ilan Meyer (2003), oferece um referencial útil para compreender como o racismo afeta a saúde mental. Embora originalmente formulada para populações sexuais minoritárias, a teoria apresenta um arcabouço conceitual que possibilita sua aplicação à análise do racismo, na medida em que a distinção entre estressores distais e proximais permite compreender como experiências estruturais de discriminação se articulam a processos subjetivos internalizados (Frost & Meyer, 2023).

Os estressores distais referem-se a experiências objetivas de discriminação, como abordagens policiais, insultos, humilhações públicas, falta de acesso a dispositivos de acesso. Já os estressores proximais dizem respeito aos processos subjetivos produzidos por essa exposição contínua, como a expectativa constante de rejeição, a hipervigilância, o medo antecipatório de novas violências e a internalização de estereótipos raciais negativos (Aguilar & Teixeira, 2022; Mata & Pelisoli, 2016).

A combinação desses estressores contribui para um desgaste psicológico cumulativo, que se expressa tanto em sofrimento emocional quanto em repercussões físicas, como maior incidência de hipertensão e outras doenças cardiovasculares, demonstrando que saúde física e mental andam juntas (Faro & Pereira, 2011; Holmes et al., 2024).

A Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano complementa essa análise ao oferecer um modelo que permite compreender fenômenos sociais complexos a partir de

sistemas ecológicos interdependentes (Sadownik, 2023). Dessa forma, conseguimos situar o racismo como um fenômeno que atravessa diferentes níveis do ambiente. Conforme sintetizado na Tabela 1, o racismo se manifesta no microsistema, mesossistema, exossistema e macrosistema, articulando experiências interpessoais, práticas institucionais e ideologias sociais que produzem impactos cumulativos sobre a saúde mental da população negra ao longo do tempo, conforme discutido por Werneck (2016).

Considerando o que foi discutido nesse tópico, podemos entender que o racismo atua como preditor do adoecimento psíquico da população negra, o que impõe à Psicologia o desafio de pensar suas formas de intervenção a fim de promover um cuidado contextualizado.

Tabela 1

Integração entre a teoria de estresse de minorias e teoria bioecológica

Nível da Teoria Bioecológica	Contexto adaptativo	Contexto com estressores raciais	Estressor (Proximal ou Distal)
Microsistema (relações diretas: família, escola, amigos)	Criança recebe apoio emocional dos pais e professores na escola	Criança negra sofre bullying e é desvalorizada academicamente pelos professores	Distal (discriminação interpessoal)
Mesossistema (interações entre microsistemas)	Pais participam ativamente da vida escolar dos filhos e têm boa comunicação com professores	Pais negros enfrentam barreiras para serem ouvidos na escola dos filhos, afetando o suporte educacional	Proximal (expectativa de rejeição)
Exossistema (ambientes que influenciam indiretamente)	Oportunidades de emprego e moradia acessíveis, influenciando indiretamente o bem-estar	Segregação habitacional e barreiras no mercado de trabalho limitam as oportunidades de ascensão social	Distal (desigualdade estrutural)
Macrossistema (valores culturais, leis, ideologias)	Sociedade valoriza diversidade e equidade racial nas políticas públicas	Normalização de estereótipos raciais e políticas excludentes reforçam desigualdades	Distal (racismo estrutural)

Cronossistema (mudanças ao longo do tempo)”	Expansão de políticas afirmativas melhora as condições de vida das minorias	Acúmulo de experiências racistas ao longo da vida gera impacto na saúde mental	Distal e Proximal (impacto cumulativo)
---	---	--	--

Nota. Tabela elaborada pela autora através da articulação entre as teorias

Manejo clínico e competências culturais

Diante dos efeitos do racismo sobre a saúde mental da população negra, torna-se insuficiente uma prática psicológica que se restrinja a modelos universalizantes ou que trate o sofrimento apresentado de forma descontextualizada. No campo clínico, diferentes estudos brasileiros tem indicado que o manejo do sofrimento atravessado pelo racismo exige que o psicólogo seja capaz de reconhecer, nomear e sustentar clinicamente experiências de discriminação racial, compreendendo-as como parte constitutiva da queixa e não como elemento secundário ou externo ao processo terapêutico (Damasceno & Zanello, 2022; Ferreira et al., 2022; Santos et al., 2023; Silva & Carneiro, 2022).

Pesquisas recentes feitas com clientes negros em psicoterapia apontam que a invisibilização do racismo no setting clínico pode fragilizar a aliança terapêutica, produzir sentimentos de não reconhecimento e limitar a elaboração do sofrimento, favorecendo inclusive o abandono precoce do processo terapêutico (Damasceno & Zanello, 2022; Farias et al., 2024). Em contrapartida, propostas de clínica antirracista e contextualizada destacam a importância de validar as experiências de discriminação, compreender os impactos do racismo na construção identitária e situar o sofrimento em uma rede de determinantes sociais e institucionais (Ferreira et al., 2022; Furini et al., 2023; Weiss et al., 2023).

Nesse cenário, consolida-se a compreensão de que o manejo clínico do racismo não depende apenas de boa intenção ou sensibilidade individual, mas de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitam ao terapeuta ajustar sua escuta, formulação de caso e intervenções às experiências racializadas dos pacientes (Page et al., 2024). É nesse ponto que emerge, sobretudo na literatura internacional, o debate sobre

competências multiculturais, inicialmente sistematizado a partir da década de 1960 e posteriormente formalizado em diretrizes profissionais como as “Multicultural Guidelines: An Ecological Approach to Context, Identity, and Intersectionality” (APA, 2017; Sue et al., 1992).

Embora não haja uma definição única do construto, as competências multiculturais são geralmente compreendidas como uma postura metodológica envolvendo: (a) consciência crítica sobre valores, crenças e posições sociais do(a) terapeuta; (b) conhecimento sobre desigualdades, racismo e experiências de grupos minorizados; e (c) habilidades para adaptar a prática clínica de forma sensível às desigualdades estruturais e a contextos culturais diversos (Davis et al., 2018; Hays, 2009, 2009; Page et al., 2024; Sue et al., 1992). No contexto brasileiro, esse debate tem sido articulado a propostas de psicologia antirracista e de práticas clínicas sensíveis às interseccionalidades, reforçando que considerar raça e racismo no atendimento faz parte do cuidado efetivo (Ferreira et al., 2022; Furini et al., 2023; Teixeira et al., 2025).

A ausência dessas competências tem sido associada a consequências clínicas relevantes, como dificuldades na aliança terapêutica, menor adesão ao tratamento e experiências de microagressões no cuidado, especialmente quando o sofrimento racializado é minimizado ou reinterpretado de forma individual (Damasceno & Zanello, 2022; Farias et al., 2024). Por essa razão, modelos como o ADDRESSING (Hays, 2024) têm sido utilizados como ferramentas de organização clínica, auxiliando o terapeuta a mapear dimensões identitárias e contextuais que atravessam o caso, sem reduzir a experiência do paciente a um padrão universal, além de poder se autoavaliar em relação aos marcadores de seu cliente, a fim de identificar pontos que possam interferir na relação terapêutica.

Se, por um lado, a literatura aponta a centralidade das competências multiculturais para o manejo clínico junto a grupos racialmente minorizados, por outro, evidencia-se a

necessidade de instrumentos que permitam avaliar e sistematizar esse repertório na formação e na prática profissional. No contexto brasileiro, Ronzani et al. (2025) produziram evidências de validade de uma escala de competências culturais voltada a profissionais da saúde; entretanto, ainda são escassos instrumentos direcionados especificamente à Psicologia clínica e às particularidades do atendimento psicoterapêutico a populações minorizadas.

Nessa lógica, a adaptação de um instrumento de avaliação das competências multiculturais voltado a psicólogos clínicos insere-se como estratégia fundamental para identificar déficits formativos, orientar processos de qualificação profissional e subsidiar práticas clínicas mais contextualizadas e culturalmente responsivas. Ao permitir a mensuração sistemática desse construto, instrumentos dessa natureza contribuem tanto para a pesquisa quanto para a formação e o aprimoramento da prática profissional, o que justifica o objetivo central do presente estudo.

Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI)

O Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) foi desenvolvido por Suarez-Balcazar et al. (2011) com o objetivo de avaliar competências culturais de profissionais da área da saúde, a partir de uma concepção multidimensional do construto. Os autores partem do entendimento de que a competência cultural não se restringe a atitudes individuais, mas também envolve articulação entre consciência crítica, habilidades profissionais e condições organizacionais que sustentem práticas sensíveis à diversidade cultural. A construção do instrumento foi fundamentada em uma revisão da literatura sobre competência cultural e em modelos teóricos consolidados no campo (Suarez-Balcazar et al., 2011).

O desenvolvimento do instrumento envolveu diferentes etapas, incluindo análise de modelos conceituais existentes, elaboração inicial de itens, avaliação por especialistas e análises psicométricas subsequentes. A partir desses procedimentos, os autores propuseram

um instrumento composto por 24 itens, organizados em uma escala do tipo Likert de 6 pontos, visando captar diferentes dimensões da competência cultural de forma integrada. As análises fatoriais exploratórias e confirmatórias realizadas no estudo sustentaram uma estrutura composta por três fatores correlacionados que serão apresentados a seguir (Suarez-Balcazar et al., 2011).

A primeira dimensão, denominada consciência cultural, refere-se à capacidade do profissional de reconhecer seus próprios valores, crenças e vieses culturais, bem como de identificar a existência de desigualdades, discriminação e racismo nos contextos de cuidado (Suarez-Balcazar et al., 2011). A segunda dimensão, habilidades culturais, diz respeito à capacidade de adaptar práticas profissionais, comunicação e intervenções às necessidades de indivíduos e grupos culturalmente diversos. Já a terceira dimensão, suporte organizacional, avalia a percepção dos profissionais sobre o apoio institucional para a adoção de práticas culturalmente competentes, incluindo políticas, recursos e oportunidades de formação continuada (Suarez-Balcazar et al., 2011).

Os autores enfatizam que essas dimensões não operam de forma isolada, mas se articulam na produção de práticas mais equitativas e responsivas às diferenças culturais. Ao incorporar o nível organizacional à avaliação das competências culturais, o CCAI amplia abordagens centradas exclusivamente no indivíduo e se alinha a perspectivas que reconhecem os determinantes sociais e institucionais da prática em saúde (Suarez-Balcazar et al., 2011).

Embora o instrumento tenha sido desenvolvido no contexto norte-americano, seus fundamentos teóricos dialogam com debates contemporâneos da Psicologia clínica, especialmente no que se refere à adaptação da prática profissional, ao reconhecimento de desigualdades estruturais e ao cuidado com populações historicamente minorizadas (APA 2017; Davis et al., 2018; Page et al., 2024; Suarez-Balcazar et al., 2011; Sue et al., 1992).

Objetivos

Objetivo geral: Oferecer um instrumento com boas evidências de validade para uso em pesquisas e formações voltadas para competências multiculturais no Brasil.

Objetivos específicos:

- a) Traduzir e adaptar o CCAI ao contexto brasileiro, ajustando itens ao contexto sociocultural do país.
- b) Avaliar a validade fatorial e consistência interna do instrumento em psicólogos brasileiros.

Capítulo II: Artigo

Nota: a versão completa deste artigo será disponibilizada no Lume- Repositório Digital da UFRGS após a sua publicação em revista, no prazo máximo de dois anos desde seu envio ao repositório.

Adaptação transcultural do Cultural Competence Assessment Instrument para psicólogos clínicos no Brasil

Ellen Dias Romero, Leticia Sanguinetti Czepielewski, Evandro Moraes Peixoto

Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS)

Resumo

Este artigo teve como objetivo realizar a adaptação transcultural do Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) para o contexto da Psicologia clínica brasileira e reunir evidências iniciais de validade de conteúdo. Trata-se de estudo metodológico, quantitativo e transversal, conduzido em duas etapas: tradução e adaptação transcultural, seguida de pré-teste por grupos focais. Participaram quatro tradutores bilíngues, um especialista em Psicometria e oito psicólogos clínicos. As análises qualitativas indicaram adequada equivalência semântica, idiomática e conceitual entre a versão original e a adaptada. Os principais ajustes envolveram refinamentos terminológicos e adequações ao contexto da prática clínica contemporânea, incluindo atendimentos presenciais e online. A versão final, denominada CCAI-BR, manteve os 24 itens e a estrutura trifatorial original. Os achados sugerem que o instrumento apresenta potencial para subsidiar práticas clínicas antirracistas, processos formativos e futuras investigações psicométricas no Brasil.

Palavras-chave: competência multicultural; adaptação transcultural; psicometria; diversidade cultural; avaliação profissional

Abstract

This study aimed to culturally adapt the Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) to the Brazilian clinical psychology context and gather initial content validity evidence. This was a methodological, quantitative, cross-sectional study conducted in two stages: translation and cross-cultural adaptation, followed by focus-group pretesting. Participants included four bilingual translators, one psychometrics expert, and eight clinical psychologists. Qualitative analyses indicated adequate semantic, idiomatic, and conceptual equivalence between the original and adapted versions. Main adjustments involved terminological refinements and adaptations to contemporary clinical practice, including in-person and online services. The final version, named CCAI-BR, retained the original 24 items and three-factor structure. Findings suggest that the instrument may support antiracist clinical practices, professional training, and future psychometric investigations in Brazil.

Keywords: cultural competence; race relations; validation studies; ethnic minorities

As demandas clínicas relacionadas às desigualdades raciais evidenciam a necessidade de instrumentos capazes de avaliar se o psicólogo dispõe de competências adequadas para lidar com diversidade cultural e racial na atuação psicológica. No Brasil, o racismo estrutural produz impactos significativos sobre a saúde física e mental da população negra, configurando-se como importante determinante social de saúde (Santos et al., 2023). Estudos nacionais indicam que a vivência cotidiana do racismo, em suas formas diretas e indiretas, atua como estressor crônico, associado a prejuízos persistentes no bem-estar e na saúde geral (Faro & Pereira, 2011; Mata & Pelisoli, 2016; Santos & Dias, 2022). No campo da saúde mental, tais experiências têm sido relacionadas ao desenvolvimento de sintomas ansiosos, depressivos e traumáticos, incluindo os efeitos cumulativos das microagressões raciais cotidianas (Damasceno & Zanello, 2022).

A Psicologia, contudo, historicamente conferiu atenção limitada às repercussões subjetivas do racismo. Kilomba (2019) argumenta que a marginalização do tema nos debates acadêmicos produziu uma importante lacuna teórica e técnica acerca das experiências de pessoas racializadas. No contexto brasileiro, o Conselho Federal de Psicologia (2017) reconhece que a profissão foi atravessada por paradigmas eugenistas e eurocêtricos, sustentando referenciais normativos baseados em ideais brancos, europeus e masculinos. Essa herança repercute em processos formativos que frequentemente tratam a dimensão racial como tema periférico, limitando a compreensão clínica do sofrimento psíquico da população negra e elevando o risco de práticas iatrogênicas (Tavares & Trad, 2021).

Na prática clínica, a insuficiente preparação para o manejo das relações raciais pode comprometer a qualidade do cuidado ofertado. A ausência de repertório técnico para reconhecer e intervir sobre os impactos do racismo no setting terapêutico tende a dificultar a

aliança terapêutica, fragilizar vínculos e contribuir para a interrupção precoce do tratamento por parte de clientes negros (Tavares & Kuratani, 2019; Weiss et al., 2023). Torna-se, portanto, necessário que a Psicologia clínica incorpore referenciais capazes de reconhecer como raça, cultura e desigualdade atravessam processos subjetivos e relações de cuidado.

Diante desse cenário, a busca pela superação dessas lacunas convergem diretamente com os preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005). Ao determinar que o psicólogo deve atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural, torna-se um imperativo ético que os profissionais busquem ativamente eliminar quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, bem como mantenham-se atentos às relações de poder nos contextos em que atua e seus impactos sobre as suas atividades profissionais (CFP, 2005).

Nesse contexto, as competências multiculturais emergem como resposta ética e técnica às limitações dos modelos tradicionais de formação e prática. De modo geral, referem-se ao conjunto de atitudes, conhecimentos e habilidades que permitem ao profissional atuar de forma eficaz junto a pessoas de diferentes pertencimentos culturais, reconhecendo os marcadores sociais que impactam suas trajetórias e adaptando intervenções às suas necessidades específicas (Page et al., 2024). As *Multicultural Guidelines* da American Psychological Association (2017) também reforçam a importância de que psicólogos reconheçam sua própria inserção sociocultural, compreendam dinâmicas de poder, privilégio e opressão e ajustem suas práticas às realidades dos clientes.

Entretanto, o desenvolvimento dessas competências exige também formas sistemáticas de avaliação, e nesse sentido, instrumentos psicométricos permitem operacionalizar construtos, observar lacunas formativas, avaliar intervenções e subsidiar

decisões institucionais. No Brasil, embora existam avanços recentes, como a validação da Escala Multidimensional de Competência Cultural para profissionais da saúde (Ronzani et al., 2025) e proposições voltadas a uma avaliação psicológica antirracista (Barros, 2025), permanece escassa a disponibilidade de medidas especificamente voltadas à prática clínica em Psicologia.

Entre os instrumentos disponíveis internacionalmente, destaca-se o *Cultural Competence Assessment Instrument* (CCAI), desenvolvido na Universidade de Illinois, em Chicago, por Suarez-Balcazar et al. (2011). O instrumento originalmente foi desenvolvido para profissionais da reabilitação, contudo, os autores pontuaram que sua aplicabilidade pode ser ampliada para outros contextos assistenciais. A ferramenta avalia competências culturais¹ através de três fatores: consciência/conhecimento cultural (reconhecimento de crenças, valores e vieses pessoais, bem como conhecimento sobre diferenças culturais), habilidades práticas (capacidade de adaptar comunicação e intervenções às necessidades socioculturais dos clientes) e suporte organizacional (percepção de apoio institucional ao desenvolvimento de práticas culturalmente responsivas). No estudo de validação original, o modelo final de 24 itens apresentou boa consistência interna global ($\alpha = 0,89$), com coeficientes das subescalas variando entre 0,76 e 0,83, além de evidências favoráveis de aplicabilidade profissional. Além disso, o instrumento contou com uma adaptação portuguesa que também demonstrou adequação psicométrica, reforçando a viabilidade de adaptação em outros contextos (Gonçalves & Matos, 2019).

Diante da escassez de ferramentas voltadas à avaliação de competências multiculturais na clínica brasileira, este estudo teve como objetivo realizar a adaptação transcultural do

¹ Embora o instrumento original adote a expressão "competência cultural" (Suarez-Balcazar et al., 2011), nesta pesquisa optou-se pelo termo "competência multicultural". Conforme discutido por Page et al. (2024), essa escolha conceitual fundamenta-se na necessidade de um afastamento crítico da noção de uma cultura única ou dominante, priorizando o reconhecimento da coexistência de múltiplas identidades culturais.

Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) para o contexto da Psicologia clínica no Brasil, além de reunir evidências iniciais de validade de conteúdo da versão adaptada.

Esperava-se que o processo de tradução e refinamento conduzido pelo comitê de especialistas resultasse em uma versão brasileira do instrumento (CCAI-BR) com equivalência semântica, conceitual e idiomática em relação à versão original. Também se hipotetizou que as avaliações qualitativas realizadas nos grupos focais indicariam boa compreensão dos itens, pertinência prática e aplicabilidade da escala à realidade contemporânea da atuação clínica no país, contribuindo para sustentar a validade conceitual do instrumento junto ao público-alvo.

Capítulo III: Evidências psicométricas preliminares e desafios na pesquisa

Este capítulo apresenta os resultados empíricos obtidos na segunda etapa do estudo, a partir da aplicação da versão brasileira do CCAI em psicólogos brasileiros. A coleta de dados encontra-se em andamento e, até o momento, possibilitou a apresentação da caracterização dos participantes, bem como a discussão de evidências psicométricas preliminares do instrumento.

Considerando o estágio da pesquisa, optou-se por uma abordagem analítica dos dados disponíveis, sem a fixação de conclusões definitivas acerca da estrutura psicométrica do instrumento. Assim, os resultados aqui apresentados buscam contribuir para a reflexão sobre a formação e atuação dos psicólogos no que se refere às competências multiculturais, em consonância com os objetivos gerais da dissertação.

Ainda não foi possível sustentar análises psicométricas conclusivas quanto à estrutura fatorial do CCAI-BR. Dessa forma, os resultados aqui apresentados não têm como objetivo finalizar a produção de evidências de validade, mas relatar as limitações encontradas nesta etapa e refletir sobre os desafios metodológicos e contextuais envolvidos na investigação das competências multiculturais na Psicologia clínica brasileira.

Método

Participantes e procedimentos

Participaram do estudo 112 psicólogos clínicos, correspondendo a aproximadamente um terço do tamanho amostral inicialmente calculado. Os critérios de inclusão foram: psicólogos com inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e atuação clínica. Como critérios de exclusão, consideraram-se estagiários, profissionais sem experiência clínica e participantes que não completaram todas as etapas do estudo.

A amostra foi composta por participantes com idades entre 23 e 77 anos ($M = 36,6$; $DP = 11,3$). Em relação à identidade de gênero, observou-se predominância de participantes que se identificaram como mulheres cisgênero (76,8%), seguidos por homens cisgênero (18,8%), mulheres transgênero (1,8%) e pessoas não binárias (2,7%).

No que se refere à raça/cor autodeclarada, a maioria dos participantes se identificou como pessoas brancas (65,2%), seguida de pessoas pardas (19,6%) e pretas (10,7%). Ressalta-se que essa variável permitiu múltipla marcação.

Quanto à orientação sexual, prevaleceram participantes heterossexuais (58%), seguidos por bissexuais (25%), homossexuais (9,8%), pansexuais (3,6%) e assexuais (2,7%).

Em relação à presença de deficiência, a maioria dos participantes relatou não possuir nenhum tipo de deficiência (95,5%), enquanto 4,5% indicaram possuir algum tipo de deficiência.

Por fim, no que diz respeito à religião ou crença religiosa, observou-se diversidade de respostas, com maior frequência de participantes que se identificaram como ateus, católicos, espíritas e praticantes de religiões de matriz africana, além de participantes que relataram não possuir religião ou crença.

Instrumentos

Além da versão adaptada do Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI), os participantes também responderam aos seguintes instrumentos:

Formulário Sociodemográfico: Incluiu 18 perguntas destinadas à caracterização da amostra, como idade, gênero, raça/cor, formação acadêmica, abordagem teórica, tempo de atuação clínica e experiências prévias com temas relacionados à diversidade racial.

Escala de Eficácia Antirracista: Composta por 4 itens, respondidos em escala Likert de 4 pontos, destinada a avaliar a percepção dos participantes sobre sua própria autoeficácia em

ações individuais ou coletivas de enfrentamento ao racismo. Com consistência interna considerada aceitável (0,68), obteve evidências de validade ao se correlacionar positiva e significativamente com indicadores de Justiça Social e de Contribuição para a Comunidade/Sociedade em geral (Romano et al., 2025).

Escala de Consciência Crítica (ECC-36). Instrumento composto por 24 itens respondidos em escala Likert de 4 pontos, avaliando percepção de injustiças sociais, autoeficácia sociopolítica e engajamento em ações orientadas para justiça social e equidade (Peixoto et al., no prelo).

Procedimentos de coleta de dados

A coleta ocorreu de forma online, por meio de um formulário elaborado no Google Forms, entre os meses de agosto e dezembro de 2025. A divulgação foi realizada por e-mail, redes sociais e grupos profissionais da área da Psicologia, seguindo os critérios de inclusão previamente estabelecidos. Como forma de incentivo à participação, ao final da pesquisa, os participantes tiveram acesso a uma aula gratuita sobre competências multiculturais na prática clínica.

Resultados

Evidências psicométricas preliminares

As análises estatísticas foram realizadas nos softwares *Jamovi* e *R*. Inicialmente, o *Jamovi* foi utilizado para a condução das análises descritivas, com o objetivo de caracterizar a amostra quanto às variáveis sociodemográficas. As análises psicométricas foram conduzidas no software *R* e *R Studio*. Foram empregados estimadores adequados para dados categóricos visando lidar com possíveis violações da normalidade e o tamanho amostral reduzido.

A adequação da matriz de correlações para análises fatoriais foi verificada por meio do índice Kaiser-Meyer-Olkin ($KMO = 0,769$) e do Teste de Esfericidade de Bartlett, que se mostrou estatisticamente significativo ($\chi^2(276) = 1062,8; p < 0,001$), indicando que os dados

eram passíveis de fatoração. Para a definição do número de fatores, utilizou-se a Análise Paralela, técnica amplamente recomendada na literatura psicométrica, a qual sugeriu a extração de cinco fatores.

A partir dessa verificação, foram testados modelos de Análise Fatorial Confirmatória (AFC) de três e cinco fatores com o objetivo de avaliar a adequação da estrutura teórica do instrumento aos dados desta etapa do estudo. O modelo de três fatores corresponde à estrutura original do instrumento, conforme proposto no estudo de desenvolvimento do CCAI (Suarez-Balcazar et al., 2011). O modelo de cinco fatores, por sua vez, foi especificado com base nos resultados da análise paralela, procedimento utilizado para subsidiar a decisão acerca do número de fatores a serem retidos, o qual indicou essa solução como a mais adequada para os dados desta amostra. Entretanto, os índices de ajuste globais observados para o modelo de cinco fatores não atingiram os valores de referência descritos na literatura, com CFI = 0,79 e TLI = 0,75, abaixo do ponto de corte recomendado ($\geq 0,90$), bem como RMSEA = 0,09 e SRMR = 0,09, acima dos valores considerados aceitáveis ($\leq 0,08$), indicando inadequação do modelo aos dados observados. (Hu & Bentler, 1999).

A literatura psicométrica aponta que a estabilidade dos índices de ajuste e das soluções fatoriais é fortemente influenciada pelo tamanho amostral, pela complexidade do modelo e pela variabilidade do traço latente (Golino et al., 2021). Na presente etapa do estudo ($n = 112$), a relação entre o número de participantes e o número de itens do instrumento (24) encontra-se abaixo do recomendado para análises fatoriais confirmatórias, o que pode resultar em soluções instáveis e inflação do erro de medida.

Diante desses resultados, optou-se por não avançar na interpretação da estrutura interna do instrumento nesta etapa, evitando inferências estruturais que poderiam ser artificiais ou instáveis. Assim, as evidências psicométricas aqui apresentadas devem ser compreendidas como preliminares, mantendo-se o caráter exploratório das análises enquanto

a coleta de dados segue em andamento, com vistas a possibilitar avaliações estruturais mais robustas em etapas posteriores.

No que se refere à fidedignidade, a análise de consistência interna indicou um Alfa de Cronbach de 0,71, valor considerado aceitável para estudos exploratórios. Conforme discutido na literatura, o coeficiente alfa é sensível tanto à correlação média entre os itens quanto ao número de itens que compõem o instrumento, de modo que escalas mais extensas tendem a apresentar valores moderados, especialmente em fases iniciais de validação. Assim, o valor observado sugere consistência interna preliminar dos escores, sem implicar, nesta etapa, conclusões estruturais definitivas.

Discussão

Esta etapa do estudo não atingiu o número amostral inicialmente previsto para a realização de análises psicométricas robustas. A divulgação da pesquisa ocorreu ao longo de aproximadamente cinco meses, de forma frequente, abrangendo múltiplos canais institucionais e informais, incluindo centros acadêmicos, programas de pós-graduação em Psicologia, conselhos regionais, associações profissionais, grupos de networking de psicólogos, instituições de ensino, além de redes sociais e convites via e-mail. Ainda assim, a amostra final contou com cerca de $\frac{1}{3}$ do necessário.

Levantamos alguns questionamentos que podem nos ajudar a entender o baixo engajamento dos participantes. Um primeiro aspecto refere-se aos desafios estruturais da pesquisa científica no Brasil, marcados pela desvalorização da ciência, pela escassez de recursos e pela ausência de incentivos materiais, especialmente em estudos de participação voluntária. Além disso, o uso de questionários autoaplicáveis em ambiente virtual, embora amplie o alcance geográfico, apresenta limitações (Bastos et al., 2023). Entre elas, teorizamos o esquecimento por parte dos participantes após o primeiro contato, a sobrecarga de convites simultâneos para diferentes pesquisas, a priorização seletiva de temas percebidos como mais

relevantes e a desistência em função do tempo necessário para o preenchimento do instrumento. No caso do CCAI-BR, o tempo médio de resposta era de 15 minutos, o que pode ter sido considerado excessivo para alguns participantes, especialmente em um contexto de múltiplas demandas profissionais. A impossibilidade de oferecer compensações financeiras ou outros incentivos concretos pode ter impactado a disposição dos profissionais em participar da pesquisa.

Outro questionamento diz respeito ao foco temático da pesquisa, centrado nas competências multiculturais no atendimento clínico à população negra. Tal recorte exige reconhecer a raça como um eixo transversal que atravessa a prática clínica, a formação profissional e a produção de conhecimento em Psicologia. A literatura aponta que questões raciais historicamente foram invisibilizadas na Psicologia, sendo frequentemente silenciadas ou tratadas de forma individualizante, o que contribui para a baixa incorporação do tema tanto na formação quanto na prática profissional (Damasceno & Zanello, 2022, 2018; Nascimento & Silva, 2021; Zamora, 2012)

Tendo em vista a crítica de Kilomba (2019) acerca das reações defensivas da branquitude diante da nomeação do racismo e do questionamento de sua posição normativa, pode-se levantar a hipótese de que pesquisas que demandam reflexão sobre práticas profissionais, privilégios raciais e implicações éticas encontrem maior resistência, especialmente quando direcionadas a grupos racialmente hegemônicos. Dessa forma, a baixa adesão ao estudo pode, portanto, relacionar-se ao desconforto envolvido no reconhecimento de lacunas formativas e de possíveis limitações no manejo clínico do racismo, já apontadas em estudos sobre a prática psicológica no atendimento à população negra (Damasceno & Zanello, 2022; Ferreira et al., 2022).

Uma possível interpretação desse fenômeno pode ser articulada ao conceito de pacto narcísico da branquitude, proposto por Bento (2002), que descreve acordos implícitos de silêncio, negação e evitação do debate racial como estratégia de manutenção do status quo. Embora não seja possível afirmar empiricamente que esse mecanismo tenha operado, sua formulação teórica oferece uma lente interpretativa para compreender resistências à implicação em pesquisas que tensionam a centralidade da branquitude na produção do saber psicológico.(Almeida, 2019; Bento, 2002; Zamora, 2012).

Do ponto de vista ético-profissional, essa dinâmica acarreta implicações significativas. O Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) estabelece como princípios fundamentais o compromisso com a promoção da dignidade, da igualdade e da integridade humana, bem como a eliminação de todas as formas de negligência, discriminação e violência. Além do mais, orienta que o exercício profissional deve considerar criticamente a realidade social, política e cultural, reconhecendo seus determinantes históricos (CFP, 2005).

Nessa perspectiva, ignorar a relevância do racismo como determinante social da saúde implica o risco de práticas que desconsideram o contexto de opressão vivido pela população negra, podendo resultar em intervenções e iatrogênicas e no reforço de processos patologizantes (Tavares & Trad, 2021), além de configurar falha ética, uma vez que os princípios do código de ética não são cumpridos, afinal, só combatemos essas desigualdades se entendermos como elas operam. Sob essa óptica, a baixa participação em pesquisas voltadas à qualificação da prática profissional também pode ser compreendida como um obstáculo à produção de conhecimento científico comprometido com a equidade racial e com a promoção de saúde mental de populações historicamente marginalizadas (Damasceno & Zanello, 2022; Ferreira et al., 2022; da Silva, 2021; Tavares & Trad, 2021).

Ainda que não seja possível estabelecer relações causais a partir dos dados disponíveis, os resultados desta etapa permitem levantar a hipótese de que o racismo segue operando de forma estrutural, inclusive no campo da pesquisa, dificultando investigações que buscam produzir conhecimento crítico e aplicado e contribuindo para a manutenção de lacunas empíricas.

Considerações finais

Apesar dos desafios e limitações da etapa atual do estudo, reafirma-se a centralidade das competências multiculturais para um fazer psicológico ético, baseado em evidências e comprometido com a justiça social (Conselho Federal de Psicologia, 2005; Ferreira et al., 2022; Furini et al., 2023). A continuidade da coleta de dados permanece como objetivo do projeto, visando à produção de evidências psicométricas mais robustas para a versão brasileira do CCAI em estudos futuros.

Entendemos que o CCAI-BR pode subsidiar processos formativos e fomentar a reflexão crítica sobre a prática profissional, ampliando o debate sobre relações raciais nos contextos de formação e atuação em Psicologia.

Por fim, reconhecemos que o caminho para a equidade racial e para a reparação dos efeitos dos mais de três séculos de escravização e violência racial ainda é atravessado por resistências. Ainda assim, sustentamos uma Psicologia que não é omissa frente às desigualdades e que se implica eticamente na transformação social.

Referências

- Aguilar, T., & Teixeira, M. T. N. P. (2022). Dimensões psicossociais do racismo e o sujeito em sofrimento: Possíveis contribuições da psicologia para a construção da identidade da pessoa negra. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, 4(1).
<https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/975>
- Aiquoc, K. M., Santos, V. B. P., Oliveira, K. B. de, & Batista, L. E. (2021). Política nacional de saúde integral da população negra: História, avanços e desafios. Em *Raça e Saúde: Múltiplos olhares sobre a saúde da população negra no Brasil* (p. 12–34). EDUFRN.
- Almeida, S. (2019). *Racismo estrutural*. Pólen Produção Editorial LTDA.
- Alves, R. M., & Lucena, B. A. de. (2021). As repercussões do racismo na saúde mental da população negra. Em I. R. Barbosa, K. M. Aiquoc, & T. A. de Souza (Org.), *Raça e Saúde: Múltiplos olhares sobre a saúde da população negra no Brasil* (p. 159–168). EDUFRN.
- American Psychological Association. (2017). *Multicultural Guidelines: An Ecological Approach to Context, Identity, and Intersectionality*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/e501962018-001>
- Barros, L. de O. (2025). Avaliação psicológica e questões étnico-raciais: Propostas antirracistas para o contexto brasileiro. *Avaliação Psicológica*, 24(SPE1).
<https://doi.org/10.15689/ap.2025.24.e25436>
- Bastos, J. E. de S., Sousa, J. M. de J., Silva, P. M. N. da, & Aquino, R. L. de. (2023). O uso do questionário como ferramenta metodológica: Potencialidades e desafios. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 5(3), 623–636.
<https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n3p623-636>

- Batista, W. M., & Mastrodi, J. (2018). Dos fundamentos extraeconômicos do racismo no Brasil. *Revista Direito e Práxis*, 9, 2332–2359.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1590/2179-8966/2018/30077>
- Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. *Spine*, 25(24), 3186–3191. <https://doi.org/10.1097/00007632-200012150-00014>
- Bento, M. A. da S. (2002). *Pactos narcísicos no racismo: Branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público*. [Tese, Universidade de São Paulo].
<https://doi.org/10.11606/T.47.2019.tde-18062019-181514>
- Borsa, J. C., Damásio, B. F., & Bandeira, D. R. (2012). Adaptação e validação de instrumentos psicológicos entre culturas: Algumas considerações. *Paidéia (Ribeirão Preto)*, 22, 423–432.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S0103-863X2012000300014>
- Brasil. Ministério da Saúde. (2017). *Política nacional de saúde integral da população negra: Uma política para o SUS* (p. 44).
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacao_negra_3d.pdf
- Conselho Federal de Psicologia. (2005). *Código de ética profissional do psicólogo*. CFP.
<https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf>
- Conselho Federal de Psicologia. (2017). *Relações raciais: Referências técnicas para atuação de psicólogas(os)*. Conselho Federal de Psicologia.
- Conselho Federal de Psicologia. (2022). *Quem faz a Psicologia brasileira?* (V. 1–2). Conselho Federal de Psicologia.
- Cunha, R. de O., Leite, I. C. G., Nogueira, M. C., & Cruz, D. T. da. (2024). Raça e racismo: Aspectos conceituais, históricos e metodológicos para pesquisas antirracistas em

saúde. *Saúde e Sociedade*, 33, e230590pt.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S0104-12902024230590pt>

Damasceno, M. G., & Zanello, V. M. (2022). Psicoterapeutas brancos/as e clientes negros/as: Sobre racismo invisível e lacuna em relações raciais na formação profissional. *Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN)*, 14(42), 317–342.

Damasceno, M. G., & Zanello, V. M. L. (2018). Saúde mental e racismo contra negros: Produção bibliográfica brasileira dos últimos quinze anos. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 38, 450–464. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/1982-37030003262017>

Davis, D. E., DeBlaere, C., Owen, J., Hook, J. N., Rivera, D. P., Choe, E., Van Tongeren, D. R., Worthington Jr., E. L., & Placeres, V. (2018). The multicultural orientation framework: A narrative review. *Psychotherapy*, 55(1), 89–100.
<https://doi.org/10.1037/pst0000160>

Domingues, P. (2005). O mito da democracia racial e a mestiçagem no Brasil (1889-1930). *Diálogos Latinoamericanos*, 6(10), 16–16. <https://doi.org/10.7146/dl.v6i10.113653>

Estrela, C., Santos, I., & Lima, R. (2021). O quesito raça/cor e a equidade no Sistema Único de Saúde: Critérios atravessados pelo contexto racial brasileiro. Em I. R. Barbosa, K. M. Aiquoc, & T. A. de Souza (Org.), *Raça e Saúde: Múltiplos olhares sobre a saúde da população negra no Brasil* (p. 49–62). EDUFRN.

Farias, T. M., Falcke, D., & Serralta, F. B. (2024). Competência multicultural das(os) psicoterapeutas na psicoterapia com pessoas negras. *Research, Society and Development*, 13(12), e04131247515–e04131247515.
<https://doi.org/10.33448/rsd-v13i12.47515>

Faro, A., & Pereira, M. E. (2011). Raça, racismo e saúde: A desigualdade social da distribuição do estresse. *Estudos de Psicologia (Natal)*, 16, 271–278.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S1413-294X2011000300009>

- Ferreira, T. A. da S., Souza, C. C. S. de, Barreto, J. L. M., Pereira, L. K. dos S., Almeida, R. S. de, & Rocha, R. de J. (2022). Princípios norteadores para uma prática clínica psicoterápica antirracista. *Acta Comportamentalia: Revista Latina de Análisis del Comportamiento*, 30(4).
<https://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/article/view/83979>
- Filho, A. F. dos S., & Silva, C. R. B. da. (2024). Racismo científico e branqueamento no Brasil Republicano (1889-1930). *Politeia - História e Sociedade*, 23(1), 17–32.
<https://doi.org/10.22481/politeia.v1i23.13536>
- Frost, D. M., & Meyer, I. H. (2023). Minority stress theory: Application, critique, and continued relevance. *Current Opinion in Psychology*, 51, 101579.
<https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101579>
- Furini, L. G., Henzel, G. A., Müller, S. A. Á. S., & Passos, J. A. F. (2023). Multiculturalidade e interseccionalidade nas terapias comportamentais contextuais. *Perspectivas em Análise do Comportamento*, 138–153. <https://doi.org/10.18761/vecc291122>
- Galvão, A. L. M., Oliveira, E., Germani, A. C. C. G., & Luiz, O. do C. (2021). Determinantes estruturais da saúde, raça, gênero e classe social: Uma revisão de escopo. *Saúde e Sociedade*, 30, e200743.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S0104-12902021200743>
- Golino, H., Moulder, R., Shi, D., Christensen, A. P., Garrido, L. E., Nieto, M. D., Nesselroade, J., Sadana, R., Thiagarajan, J. A., & Boker, S. M. (2021). Entropy Fit Indices: New Fit Measures for Assessing the Structure and Dimensionality of Multiple Latent Variables. *Multivariate Behavioral Research*, 56(6), 874–902.
<https://doi.org/10.1080/00273171.2020.1779642>

- Gonçalves, M., & Matos, M. (2019). Questionário de competências culturais para profissionais de ajuda (QCC-PA). *Psychologica*, 62, 23–40.
https://doi.org/10.14195/1647-8606_62-2_2
- Hardtke, A. G., & González, U. C. (2025). O mito de Cam: Usos racistas de uma narrativa bíblica. *Literatura e Autoritarismo*, (44), e84490–e84490.
<https://doi.org/10.5902/1679849X84490>
- Hays, P. A. (2009). Integrating evidence-based practice, cognitive–behavior therapy, and multicultural therapy: Ten steps for culturally competent practice. *Professional Psychology: Research and Practice*, 40(4), 354–360.
<https://doi.org/10.1037/a0016250>
- Hays, P. A. (2024). Four steps toward intersectionality in psychotherapy using the ADDRESSING framework. *Professional Psychology: Research and Practice*, 55(5), 454–462. <https://doi.org/10.1037/pro0000577>
- Holmes, S. C., Zare, M., Haeny, A. M., & Williams, M. T. (2024). Racial Stress, Racial Trauma, and Evidence-Based Strategies for Coping and Empowerment. *Annual Review of Clinical Psychology*, 20(Volume 20, 2024), 77–95.
<https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081122-020235>
- Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1–55.
<https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2022). *Censo Demográfico 2022: Panorama – Brasil* [Censo demográfico]. <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/?localidade=BR>

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). *Censo Demográfico 2022:*

Identificação étnico-racial da população, por sexo e idade: Resultados do universo

(p. 81). IBGE.

International Test Commission. (2017). *The ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests* (Second Edition).

https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2_brazilian_portuguese.pdf

Jones, C. P. (2002). Confronting institutionalized racism. *Phylon* (1960-), 50(1/2), 7–22.

<https://doi.org/10.2307/4149999>

Junior, J. S. M. (2021). Racismo no Brasil e racismo à brasileira: Traços originários. *O social em questão*, 2(50). <https://doi.org/10.17771/PUCRio.OSQ.52260>

Juvenil, C. B., Tavares, J. S. C., & Ventura, P. R. (2023). “Não sou eu, é a sociedade”: Terapia do esquema em um caso clínico de múltiplas opressões internalizadas. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 19(1), 125–133.

<https://doi.org/10.5935/1808-5687.20230015>

Kilomba, G. (2019). *Memórias da plantação: Episódios de racismo cotidiano*. Cobogó.

Lima, R. R. T. de, Costa, T., Souza, D. L. B. de, & Castro, J. L. de. (2021). Questões étnico-raciais da população negra na formação de profissionais da saúde: Reflexões sobre a situação brasileira. Em I. R. Barbosa, K. M. Aiquoc, & T. A. de Souza (Org.), *Raça e Saúde: Múltiplos olhares sobre a saúde da população negra no Brasil* (p. 227–240). EDUFERN.

Martins, J. R. (2023). *A depressão nas mulheres negras brasileiras: Um estudo acerca do racismo estrutural e seu impacto psíquico* | *Atas de Ciências da Saúde* (ISSN 2448-3753). <https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/ACIS/article/view/2735>

Mata, V., & Pelisoli, C. (2016). Expressões do racismo como fator desencadeante de estresse agudo e pós-traumático. *Revista Brasileira de Psicologia*, 3, 126.

- Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. *Psychological bulletin*, 129(5), 674–697. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.5.674>
- Mota, A. (2021). A eugenia como saber tecnológico e o embranquecimento como projeto político-sanitário-racial em São Paulo, 1920–1950. Em I. R. Barbosa, K. M. Aiquoc, & T. A. de Souza (Org.), *Raça e Saúde: Múltiplos olhares sobre a saúde da população negra no Brasil* (p. 63–73). EDUFERN.
- Nascimento, A., & Silva, L. M. F. da. (2021). Impactos do racismo na saúde mental da população negra brasileira. *Revista Psicoatualidades*, 1(1), 44–53.
- Page, J. O., Paveltchuk, F. de O., & Carvalho, M. R. de. (2024). Conceitualização cognitiva culturalmente competente: Uma articulação com a teoria bioecológica do desenvolvimento. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 20. <https://doi.org/10.5935/1808-5687.20240413>
- Pantoja, D. C., Rodrigues, E. C., & Abrantes, D. S. de S. (2019). O Negro e o racismo no Brasil: Ênfase nas consequências psicológicas. *Revista Arquivos Científicos (IMMES)*, 2(2), 16–22. <https://doi.org/10.5935/2595-4407/rac.immes.v2n2p16-22>
- Peixoto, E. M., Romano, A. R., da Silva, M. P. P. da S., & Gomes, M. R. (s.d.). Escala de Consciência Crítica para População Geral: Evidências de validade e precisão. *Avaliação Psicológica*.
- Queiroz, V. S., & Araújo, G. D. (2024). Branquitude, racismo e psicologia clínica: Críticas para a construção de uma clínica antirracista. *Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN)*, 15(43). <https://abpn.emnuvens.com.br/site/article/view/1616>

- Romano, A. R., Casari, C. A., & Peixoto, E. M. (2025). Justiça Social e Autoeficácia Antirracista: Adaptação de Medidas e Evidências de Validade. *Avaliação Psicológica*, 24(SPE1). <https://doi.org/10.15689/ap.2025.24.e25452>
- Ronzani, T. M., Dimenstein, M., Macedo, J. P., & Pedrero, V. (2025). Tradução e Evidências de Validade da Escala de Competência Cultural (EMCC-14) entre Profissionais de Saúde Brasileiros. *Avaliação Psicológica*, 24. <https://doi.org/10.15689/ap.2025.24.e24727>
- Sadownik, A. (2023). *Bronfenbrenner: Ecology of Human Development in Ecology of Collaboration* (p. 83–95). https://doi.org/10.1007/978-3-031-38762-3_4
- Santos, R. A. dos, & Silva, R. M. de N. B. e. (2018). Racismo científico no Brasil: Um retrato racial do Brasil pós-escravatura. *Educar em Revista*, 34, 253–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/0104-4060.53577>
- Santos, V. C. dos, & Dias, A. B. (2022). Os efeitos do racismo na saúde mental das militantes negras do MMNDS. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 42, e235483. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/1982-3703003235483>
- Santos, G. C., Brisola, E. B. V., Moreira, D., Tostes, G. W., & Cury, V. E. (2023). Impacto do racismo nas vivências de mulheres negras brasileiras: Um estudo fenomenológico. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 43, e249674. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/1982-3703003249674>
- Silva, M. C. da. (2021). Racismo: Um trauma coletivo não considerado. *Revista Latino-Americana de Psicologia Corporal*, 8(11), 38–57.
- Silva, O. H. F. da, Cruz, A. C. J. da, Mwewa, C. M., & Brito, J. E. de. (2023). Do racismo científico ao racismo social: O conceito de “raça” nas relações humanas. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, 14(40), 410–428. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866929>

- Silva, M. M. G., & Carneiro, V. T. (2022). Implicações da vivência da racialidade para a prática clínica de psicoterapeutas. *Psicologia e Saber Social*, 11(2), 407–438.
- Souza, V. S. de. (2022). Eugenia, racismo científico e antirracismo no Brasil: Debates sobre ciência, raça e imigração no movimento eugênico brasileiro (1920-1930). *Revista Brasileira de História*, 42, 93–115.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1590/1806-93472022v42n89-06>
- Suarez-Balcazar, Y., Balcazar, F., Taylor-Ritzier, T., Portillo, N., Rodakowsk, J., Garcia-Ramirez, M., & Willis, C. (2011). Development and validation of the cultural competence assessment instrument: A factorial analysis. *Journal of Rehabilitation*, 77, 4–13.
- Sue, D. W., Arredondo, P., & McDavis, R. J. (1992). Multicultural counseling competencies and standards: A call to the profession. *Journal of Counseling & Development*, 70(4), 477–486. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1992.tb01642.x>
- Tavares, J. S. C., & Kuratani, S. M. de A. (2019). Manejo clínico das repercussões do racismo entre mulheres que se “tornaram negras”. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 39, e184764. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/1982-3703003184764>
- Tavares, J. S. C., & Trad, L. A. B. (2021). Racismo e saúde mental subsídios para uma clínica socialmente contextualizada. Em I. R. Barbosa, K. M. Aiquoc, & T. A. de Souza (Org.), *Raça e Saúde: Múltiplos olhares sobre a saúde da população negra no Brasil* (p. 169–180). EDUFRN.
- Teixeira, S. K., Costa, M. H. D. da, & Stenzel, L. M. (2025). Reflexões sobre multiculturalismo e psicoterapia: Uma revisão crítica sobre o contexto brasileiro. *Práxis em Saúde*, 3(2), 01–07. <https://doi.org/10.56579/prxis.v3i2.2749>

Weiss, M., Polli, L., & Hohendorff, J. V. (2023). Considerações de estudos brasileiros para clínica psicológica com pessoas pretas. *Revista Subjetividades*, 23(1), 1–13.

<https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v23i1.e13555>

Werneck, J. (2016). Racismo institucional e saúde da população negra. *Saúde e Sociedade*, 25(3), 535–549. <https://doi.org/10.1590/s0104-129020162610>

Zamora, M. H. R. N. (2012). Desigualdade racial, racismo e seus efeitos. *Fractal: Revista de Psicologia*, 24, 563–578.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S1984-02922012000300009>

ANEXOS

ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

INSTITUTO DE PSICOLOGIA,
SERVIÇO SOCIAL, SAÚDE E
COMUNICAÇÃO HUMANA
IPSSCH/UFRGS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Adaptação do Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) para psicólogos brasileiros

Pesquisador: Leticia Sanguinetti Czepielewski

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 88298825.6.0000.5334

Instituição Proponente: Instituto de Psicologia - UFRGS

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.644.238

Apresentação do Projeto:

Este projeto visa a adaptação transcultural e a validação psicométrica do Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) (Suarez-balcazar, 2011) para o contexto brasileiro. Um instrumento que se propõe a verificar o quão culturalmente sensíveis são as práticas de profissionais da saúde. A iniciativa surge da necessidade de aprimorar a formação e atuação dos profissionais em psicologia clínica frente às desigualdades raciais, especialmente no cuidado à saúde mental da população negra - grupo historicamente vulnerabilizado pelo racismo estrutural (Werneck, 2016; Almeida, 2019). Estudos indicam que o racismo atua como um determinante social de saúde, impactando diretamente a qualidade de vida e o bem-estar psíquico desta população (da Mata & Pelisoli, 2016; Faro & Pereira, 2011). Diante disso, faz-se necessário o desenvolvimento de competências multiculturais entre os profissionais, entendidas como a habilidade contínua de reconhecer, respeitar e integrar as especificidades culturais dos pacientes ao processo terapêutico (Campinha-Bacote, 2002; Sue et al., 2009). No entanto, o campo ainda carece de instrumentos validados que permitam avaliar tais competências no Brasil. O CCAI, já validado em países como Portugal (Gonçalves & Matos, 2019), apresenta-se como uma oportunidade para a formação e avaliação das competências multiculturais dos psicólogos brasileiros. A pesquisa será composta por dois estudos. O Estudo 1 realizará a tradução e adaptação transcultural do CCAI para o português brasileiro, seguindo

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600 Sala 116

Bairro: Santa Cecília

CEP: 90.035-003

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-5698

Fax: (51)3308-5698

E-mail: cep-psico@ufrgs.br

INSTITUTO DE PSICOLOGIA,
SERVIÇO SOCIAL, SAÚDE E
COMUNICAÇÃO HUMANA
IPSSCH/UFRGS



Continuação do Parecer: 7.644.238

as diretrizes propostas por Beaton et al. (2000) e Borsa et al. (2012). O Estudo 2 consistirá na validação psicométrica do instrumento, incluindo análises de confiabilidade, validade fatorial e equivalência entre grupos. Também será aplicado um questionário sociodemográfico a fim de coletar dados sobre raça, gênero, atuação clínica e formação dos participantes. Espera-se que os resultados contribuam para fortalecer práticas psicológicas culturalmente sensíveis, éticas e alinhadas à equidade racial.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Traduzir, adaptar transculturalmente e validar psicometricamente o Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) para psicólogos brasileiros, visando promover o desenvolvimento de competências multiculturais na formação e prática clínica.

Objetivos Secundários:

- * Adaptar o CCAI ao contexto brasileiro, ajustando itens ao contexto sociocultural do país.
- * Avaliar a validade fatorial, consistência interna e estabilidade temporal do instrumento em psicólogos brasileiros.
- * Identificar diferenças na estrutura fatorial entre grupos de psicólogos com diferentes características (ex.: raça/cor, tempo de experiência).
- * Oferecer um instrumento validado para uso em pesquisas e formações voltadas para competências culturais no Brasil.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: Os riscos são mínimos, relacionados à possibilidade de desconforto ao tratar de temas sensíveis, como exclusão social. Caso isso aconteça, a equipe oferecerá acolhimento e encaminhamento adequado. Além disso, como a coleta e o armazenamento dos dados serão realizados em plataformas virtuais, como Google Forms, Google Meet e Google Drive, há riscos mínimos relacionados à segurança e à privacidade dos dados, como falhas técnicas ou acesso indevido. Para minimizar esses riscos, os dados serão anonimizados e armazenados em servidores seguros, com acesso restrito apenas à equipe responsável pela pesquisa, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Essas medidas atendem às orientações do Ofício Circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS. A participação é voluntária, e o participante pode se recusar a

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600 Sala 116
Bairro: Santa Cecília **CEP:** 90.035-003
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-5698 **Fax:** (51)3308-5698 **E-mail:** cep-psico@ufrgs.br

**INSTITUTO DE PSICOLOGIA,
SERVIÇO SOCIAL, SAÚDE E
COMUNICAÇÃO HUMANA
IPSSCH/UFRGS**



Continuação do Parecer: 7.644.238

participar ou desistir a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. É informado sobre o direito de obter informações adicionais sobre o estudo a qualquer momento.

Benefícios:

Contribuição para o avanço das práticas culturalmente competentes na Psicologia brasileira. Os participantes receberão um workshop gratuito sobre competências multiculturais como forma de incentivo à participação.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A pesquisa apresenta-se estruturada e contempla os requisitos para o estudo a ser desenvolvido.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos os termos foram apresentados e estão de acordo com as diretrizes éticas em pesquisa.

Recomendações:

Não há.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

A pesquisadora atendeu as pendências. Projeto apto a ser executado. Desejos de um bom trabalho!

Considerações Finais a critério do CEP:

Ressalta-se que cabe ao pesquisador responsável encaminhar os relatórios parciais e finais da pesquisa, por meio de Plataforma Brasil, via notificação do tipo relatório, para que sejam devidamente apreciados no CEP, conforme norma operacional CNS 001/13.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2543881.pdf	20/05/2025 12:18:40		Aceito
Outros	Resposta_CEP_IPSSCH.pdf	20/05/2025 12:12:03	ELLEN DIAS ROMERO	Aceito
Outros	CCAI_instrumento_original.pdf	20/05/2025 12:05:11	ELLEN DIAS ROMERO	Aceito
Outros	Escala_consciencia_critica.pdf	20/05/2025 12:03:21	ELLEN DIAS ROMERO	Aceito
Outros	Escala_eficacia_antirracista.pdf	20/05/2025	ELLEN DIAS	Aceito

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600 Sala 116
Bairro: Santa Cecília **CEP:** 90.035-003
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-5698 **Fax:** (51)3308-5698 **E-mail:** cep-psico@ufrgs.br

**INSTITUTO DE PSICOLOGIA,
SERVIÇO SOCIAL, SAÚDE E
COMUNICAÇÃO HUMANA
IPSSCH/UFRGS**



Continuação do Parecer: 7.644.238

Outros	Escala_eficacia_antirracista.pdf	12:02:22	ROMERO	Aceito
Outros	Formulario_sociodemografico_novo_alterado.pdf	20/05/2025 12:00:56	ELLEN DIAS ROMERO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_novo_alterado.pdf	20/05/2025 12:00:45	ELLEN DIAS ROMERO	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_alterado.pdf	20/05/2025 11:58:21	ELLEN DIAS ROMERO	Aceito
Outros	autorizacao_autores.pdf	23/04/2025 11:37:03	ELLEN DIAS ROMERO	Aceito
Folha de Rosto	folha_de_rosto.pdf	23/04/2025 11:29:52	ELLEN DIAS ROMERO	Aceito
Outros	ParecerCOMPESQ_CCAI.pdf	22/04/2025 22:14:23	ELLEN DIAS ROMERO	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 16 de Junho de 2025

Assinado por:
Oriana Holsbach Hadler
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600 Sala 116
Bairro: Santa Cecília **CEP:** 90.035-003
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-5698 **Fax:** (51)3308-5698 **E-mail:** cep-psico@ufrgs.br

ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES

14/04/2025, 01:07

Gmail - Request for Permission to Translate and Culturally Adapt the Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) for...



Ellen Romero <ellenn.romero@gmail.com>

Request for Permission to Translate and Culturally Adapt the Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) for Use in Brazil

2 mensagens

Ellen Romero <ellenn.romero@gmail.com>

8 de novembro de 2024 às 08:07

Para: ysuares@uic.edu, fabricao@uic.edu

Cc: Leticia <czepielewski@gmail.com>

Dear Dr. Suarez-Balcazar and Dr. Balcazar,

My name is Ellen Dias Romero. I am a clinical psychologist and a Master's student in the Graduate Program at the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Brazil, under the supervision of Professor Leticia Czepielewski. I am currently conducting a research project aimed at adapting and validating the Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) for Brazilian psychologists.

Given that the CCAI is a widely recognized tool for assessing cultural competence in clinical contexts, I believe that adapting it to the Brazilian context would fill a significant gap in Brazilian psychology practice, particularly in serving marginalized and diverse populations. A culturally adapted version of the CCAI will enable Brazilian psychologists to better understand and develop appropriate cultural competencies, thus addressing the specific needs of the Brazilian population, which faces unique challenges, such as structural racism and social inequalities.

To perform the translation and cross-cultural adaptation, I will follow rigorous guidelines and conduct a psychometric validation to ensure that the Brazilian version maintains the integrity and validity of the original instrument. Therefore, I respectfully request formal authorization to translate and adapt the CCAI, with the assurance that the process will adhere to the standards set forth by the International Test Commission (2017) and all necessary ethical parameters.

I am confident that this adaptation will contribute not only to clinical practice in Brazil but also to future research on cultural competence in psychology. I would also like to assure you that your team will be kept informed and duly credited throughout each stage of the process.

Thank you very much for considering this request and for the opportunity to collaborate on a project that is so relevant to mental health and cultural inclusion in Brazil. If there is any additional documentation or procedure required to formalize this authorization, please feel free to let me know.

Best regards,
Ellen Dias Romero

Suarez-Balcazar, Yolanda <ysuares@uic.edu>

8 de novembro de 2024 às 10:21

Para: Ellen Romero <ellenn.romero@gmail.com>, "Balcazar, Fabricio E" <fabricio@uic.edu>

Cc: Leticia <czepielewski@gmail.com>

Dear Ellen,

Thank you for your interest in the CCAI. Yes, you have our permission to translate, adapt and validate the CCAI in Portuguese. We do request that you please include the original citation and give credit to the original authors when referring to your adaptation in any future publication.

Please cite the attached article.

We would appreciate receiving a copy of the validated translated instrument.

Thanks,

Yolanda

ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título do Estudo: Tradução, Adaptação Transcultural e Validação Psicométrica do Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) para psicólogos brasileiros. **Responsáveis pela pesquisa:**

Profª Dra. Letícia Sanguinetti Czepielewski (orientadora, UFRGS)

Profº Dr. Evandro Morais Peixoto (coorientador, UFRGS)

Pesquisadora executora:

Ellen Dias Romero (mestranda em Psicologia – UFRGS)

Estamos convidando você para colaborar em uma pesquisa conduzida pela mestranda Ellen Dias Romero, sob responsabilidade da Profª Dra. Letícia Sanguinetti Czepielewski (orientadora) e do Profº Dr. Evandro Morais Peixoto (coorientador).

Esta pesquisa objetiva oferecer uma ferramenta que ajude a identificar lacunas na sensibilidade cultural por parte dos profissionais de psicologia, incentivando o desenvolvimento de competências multiculturais a fim de promover um atendimento mais adequado a pessoas culturalmente diversas.

O pré-requisito para participação é ter formação em psicologia, registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e atuar na área clínica.

Sua participação na pesquisa consiste em responder um questionário sociodemográfico e a versão adaptada do instrumento. O tempo previsto de participação é de cerca de 30 a 60 minutos, considerando os dois questionários.

A sua participação contribuirá para a adaptação de um instrumento que poderá qualificar a prática clínica em Psicologia no Brasil, especialmente no que se refere à atenção às diversidades culturais. Embora não haja benefícios diretos e imediatos para você, como forma de agradecimento será oferecido uma aula gratuita sobre competências multiculturais que poderá ser acessada ao final de sua participação.

Os riscos são mínimos, relacionados à possibilidade de desconforto ao tratar de temas sensíveis, como exclusão social. Caso isso aconteça, a equipe oferecerá acolhimento e encaminhamento adequado. Além disso, como a coleta e o armazenamento dos dados serão realizados em plataformas virtuais, como Google Forms, Google Meet e Google Drive, há riscos mínimos relacionados à segurança e à privacidade dos dados, como falhas técnicas ou acesso indevido. Para minimizar esses riscos, os dados serão anonimizados e armazenados em servidores seguros, com acesso restrito apenas à equipe responsável pela pesquisa, em

conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Essas medidas atendem às orientações do Ofício Circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS. Sua participação é voluntária, e você pode se recusar a participar ou desistir a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Você tem o direito de obter informações adicionais sobre o estudo a qualquer momento.

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais de nenhuma ordem, não retira os direitos previstos nos termos da Lei (art. 927 a 954 da Lei 10.406/2002 e Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012) e os procedimentos utilizados obedecem aos critérios da ética na pesquisa com seres humanos (Resolução do CNS nº 510/2016).

Os dados coletados serão armazenados em ambiente virtual protegido (Google Drive com acesso restrito) e, posteriormente, transferidos para um dispositivo eletrônico local (pen drive), sendo excluídos das plataformas virtuais utilizadas. O armazenamento físico será realizado na sala da pesquisadora responsável Letícia localizada no Instituto de Psicologia, Serviço Social, Saúde e Comunicação Humana da UFRGS (IPSSCH/UFRGS). Os dados serão mantidos por até 5 anos após o término da pesquisa e, em seguida, serão excluídos.

Os dados serão mantidos por até 5 anos após o término da pesquisa e, em seguida, serão excluídos.

Se tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a pesquisadora pelo e-mail: caplab.ufrgs@gmail.com. Para dúvidas éticas, o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia, Serviço Social, Saúde e Comunicação Humana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEP-IPSSCH/UFRGS) pode ser contatado pelo e-mail: cep-psico@ufrgs.br ou telefone (51) 3308-5698.

Ao finalizar, você receberá uma via deste termo no seu e-mail.

Agradecemos sua colaboração.

Declaração de Consentimento

Eu, declaro que fui devidamente informado(a) sobre os objetivos, procedimentos, benefícios e riscos associados a esta pesquisa. Recebi todas as informações necessárias e esclareci as minhas dúvidas.

Estou ciente de que minha participação é voluntária e que posso desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Concordo em participar deste estudo e autorizo o uso das informações fornecidas, conforme descrito neste documento.

Por favor, indique abaixo sua decisão sobre participar da pesquisa:

() Não aceito. () Sim, aceito.

Declaro que **autorizo** o armazenamento e uso dos meus dados para pesquisas futuras que avaliem aspectos relacionados.

☐ Autorizo.

☐ Não autorizo.

(você será redirecionado/a para a mensagem final da pesquisa).

Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja de seu interesse:

() quero receber os resultados da pesquisa (email para envio

: _____) () não quero receber os resultados da pesquisa

ANEXO D – FORMULÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO

Marque as alternativas que correspondem às suas informações pessoais. Em caso de mais de uma opção adequada, assinale todas as que se aplicam.

1. Orientação sexual:

☐ Heterossexual

☐ Homossexual

☐ Bissexual

☐ Assexual

☐ Pansexual

☐ Outro: _____

2. Possui alguma deficiência

☐ Não

☐ Sim

3. Se você marcou sim, especifique o tipo de deficiência que você possui: _____

4. De qual região do Brasil você é?

☐ Norte

☐ Nordeste

☐ Centro-Oeste

☐ Sudeste

☐ Sul

5. Em qual região do Brasil você reside?

☐ Norte

☐ Nordeste

☐ Centro-Oeste

☐ Sudeste

☐ Sul

☐ Moro fora do Brasil

6. Religião ou crença religiosa

☐ Católica

☐ Evangélica

☐ Espírita

☐ Religiões de matriz africana (candomblé, umbanda, etc)

☐ Ateu

☐ Outro: _____

7. Em que ano você se formou? _____

8. Participou de ações afirmativas durante a graduação (ex.: cotas raciais)?

☐ Sim

☐ Não

9. Sua formação foi realizada predominantemente em:

☐ Universidade pública

☐ Universidade privada

10. Qual é a abordagem terapêutica principal?

☐ Terapias Cognitivo-Comportamentais (TCC's)

☐ Psicanálise

☐ Humanista

☐ Sistêmica/familiar

☐ Outro: _____

11. Quantos pacientes você atende, em média, por mês?

☐ 1-10

☐ 11-20

☐ 21-30

☐ 31 ou mais

☐ Outro: _____

12. Quantos desses pacientes são negros (pretos ou pardos)?

☐ Nenhum

☐ 1-5

☐ 6-10

☐ 11 ou mais

13. Já recebeu supervisão específica sobre questões raciais?

☐ Sim

☐ Não

14. Tipo de atendimento que você realiza (marque TODAS as que se aplicam)

☐ Individual

☐ Grupal

☐ Familiar

☐ Casal

☐ Outro: _____

15. Você sabe o que são competências multiculturais (sensibilidade cultural, responsividade cultural, competências culturais)?

☐ Sim

☐ Não

16. Está familiarizado(a) com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra?

☐ Sim

☐ Não

17. Concorde que a formação em psicologia deveria incluir conteúdos obrigatórios sobre raça e competências multiculturais?

☐ Sim

☐ Não

☐ Indiferente

18. Quais são as principais barreiras que você enfrenta ao atender pacientes de grupos étnicos minorizados? (marque todas que se aplicam)

☐ Falta de formação específica

☐ Dificuldade em compreender as especificidades

☐ Falta de recursos ou materiais de apoio

☐ Nenhuma

☐ Outro: _____

ANEXO E – CULTURAL COMPETENCE ASSESSMENT INSTRUMENT – VERSÃO BRASILEIRA (CCAI-BR)

Cultural Competence Assessment Instrument (BR)

Instrução: Neste questionário não há respostas certas ou erradas, mas é importante você marcar com sinceridade como você se sente com relação a cada uma das afirmativas.

Para responder às questões é importante que você saiba que competências multiculturais (também chamada de responsividade cultural, competência cultural, sensibilidade cultural) são o conjunto de habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes que capacitam um profissional a interagir com outras culturas com efetividade. Ela considera a relevância da compreensão das influências sociais e culturais nas crenças e nos comportamentos de saúde dos pacientes, visando propor intervenções de qualidade (Mancebo, 2018; Page et al., 2024; Farias et al., 2024).

Como por exemplo, considerar como os atravessamentos sociais (gênero, raça, classe, deficiência, etc.) podem impactar a produção ou ausência de saúde mental. Uma mulher negra pode relatar sintomas de ansiedade intensificados por experiências de racismo no trabalho; uma pessoa trans pode apresentar quadros depressivos associados à discriminação familiar; ou ainda, um paciente em situação de vulnerabilidade socioeconômica pode ter dificuldades para aderir ao tratamento por falta de recursos.

PARTE 1: SOBRE VOCÊ

1) Você é: ☐ Mulher trans ☐ Mulher cis ☐ Homem trans ☐ Homem Cis ☐ Não binária
☐ Outro. Especifique: _____

2) Quantos anos você tem? _____

3) Qual é sua raça/etnia? (Selecione TODAS que se aplicam)

☐ branco ☐ preto ☐ pardo ☐ indígena ☐ amarelo

4) Você fala algum outro idioma além do português quando está prestando serviços? () Sim
() Não

5) Se sim, quais são esses idiomas? _____

6) Escolaridade (marque TODAS que se aplicam). Considere apenas os que você concluiu.

() Superior completo

() Mestrado

() Doutorado

() Pós graduação (especialização/formação)

7) Há quantos anos você atua na clínica? ____ anos (não considere experiências de estágio)

8) Qual dos seguintes tipos de treinamento sobre competências culturais você recebeu, se houve algum? (Marque todas as opções que se aplicam)

a) Assisti a uma disciplina/módulo obrigatória que focava ESPECIFICAMENTE neste tópico na minha trajetória acadêmica (graduação/pós)

b) Tive uma disciplina/módulo eletiva que focava ESPECIFICAMENTE neste tópico na minha trajetória acadêmica(graduação/pós)

c) Esse tópico foi abordado em diversas aulas na minha trajetória acadêmica (graduação/pós)

d) Eu aprendi sobre isso a partir da minha experiência clínica

e) Cursei oficinas de educação continuada (EC) ou cursos de EC sobre esse tópico (mini cursos; workshops, etc)

f) Adquiri conhecimento lendo sobre esse tópico por conta própria

g) Aprendi sobre isso através de supervisão clínica

h) Aprendi sobre isso através de interação multidisciplinar com outros profissionais

i) Não tive acesso a nenhum conhecimento relacionado a competências multiculturais.

PARTE 2: SOBRE O SEU TRABALHO APENAS DURANTE O ÚLTIMO ANO

Por favor circule o(s) número(s) ou complete a(s) resposta(s) correta(s) às questões a seguir

9) Indique as 3 populações que você vê com mais frequência no seu trabalho:

- a) branco
- b) preto
- c) pardo
- d) indígena
- e) amarelo

As próximas perguntas se referem à sua experiência prática com populações étnicas diversas no contexto clínico. As respostas devem refletir sua percepção pessoal sobre sua prática profissional, considerando aspectos como **acesso, avaliação, vínculo, continuidade do atendimento e intervenções**.

10) Avalie seu nível de efetividade em alcançar e/ou ser procurado por pessoas pertencentes às seguintes populações étnicas.

	Muito efetivo					Pouco efetivo
Branços	6	5	4	3	2	1
Pretos	6	5	4	3	2	1
Pardos	6	5	4	3	2	1
Indígenas	6	5	4	3	2	1
Amarelos	6	5	4	3	2	1
Outro. Por favor especifique: _____	6	5	4	3	2	1

11) Avalie a efetividade da adesão ao tratamento entre pacientes das seguintes populações étnicas

	Muito efetivo						Pouco efetivo	n/a
Branços	6	5	4	3	2	1	0	
Pretos	6	5	4	3	2	1	0	
Pardos	6	5	4	3	2	1	0	
Indígenas	6	5	4	3	2	1	0	
Amarelos	6	5	4	3	2	1	0	
Outro. Por favor especifique: _____	6	5	4	3	2	1	0	

Lembre-se de que competências multiculturais (também chamada de responsividade cultural, competência cultural, sensibilidade cultural) são o conjunto de habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes que capacitam um profissional a interagir com outras culturas com efetividade. Ela considera a relevância da compreensão das influências sociais e culturais nas crenças e nos comportamentos de saúde dos pacientes, visando propor intervenções de qualidade (Mancebo, 2018; Page et al., 2024; Farias et al., 2024).

Como por exemplo, considerar como os atravessamentos sociais (gênero, raça, classe, deficiência, etc.) podem impactar a produção ou ausência de saúde mental. Uma mulher negra pode relatar sintomas de ansiedade intensificados por experiências de racismo no trabalho; uma pessoa trans pode apresentar quadros depressivos associados à discriminação familiar; ou ainda, um paciente em situação de vulnerabilidade socioeconômica pode ter dificuldades para aderir ao tratamento por falta de recursos.

CONSIDERE A SUA PRÁTICA PROFISSIONAL DURANTE O ÚLTIMO ANO						
	Utilize como parâmetro: 6 = Concordo fortemente 1 = Discordo fortemente					
12	Sinto que sou capaz de aprender com e sobre meus clientes de grupos étnico-raciais minorizados.	6	5	4	3	2 1
13	Sinto dificuldade em adaptar minhas estratégias terapêuticas para clientes de grupos étnico-raciais minorizados.					
14	Considero-me eficaz na minha comunicação verbal (idioma, gírias, expressões, regionalismo, etc) com clientes cuja cultura é diferente da minha.					
15	Não tenho o hábito de buscar aprimoramento em competências multiculturais relacionadas a questões étnico-raciais					
16	Eu não considero as origens culturais dos meus clientes quando se trata de sua alimentação					
17	Recebo feedback de supervisores sobre como melhorar minhas habilidades práticas com clientes de grupos étnico-raciais minorizados.					
18	No meu ambiente de trabalho (consultório físico ou virtual), o material visual (decoração, quadros, materiais informativos) busca refletir a diversidade cultural e étnica					
19	Sinto-me confiante de que consigo aprender sobre as origens culturais de meus clientes					
20	Eu incluo as competências multiculturais como um princípio fundamental da minha prática profissional.					
21	Considero-me eficaz na minha comunicação não verbal (gestos, expressões faciais e corporais, vestimenta, etc.) com clientes cuja cultura é diferente da minha					
22	A forma como conduzo os meus atendimentos me traz dificuldades em identificar os valores culturais dos meus clientes.					

23	Sinto que tenho pouca experiência no trabalho clínico com clientes de grupos étnico-raciais minorizados.						
24	Sinto dificuldade em aplicar habilidades relacionadas às competências multiculturais na prática clínica. (Ex.: considerar atravessamentos de raça, classe, gênero)						
25	Eu valorizo e respeito as diferenças entre minhas origens culturais (de onde venho e como cresci) e a herança cultural (o que cada pessoa carrega e transmite) de meus clientes.						
26	Eu não costumo dedicar recursos (materiais de estudo, supervisão, cursos) para desenvolver competências multiculturais						
27	Eu tenho oportunidades de aprender sobre competências clínicas multiculturais (relacionadas a questões étnico raciais) com meus colegas						
28	Não sinto que possuo as habilidades necessárias para oferecer serviços a clientes de grupos étnico-raciais minorizados.						
29	Reflico sobre meus próprios preconceitos relacionados à raça e cultura, reconhecendo como podem influenciar minha atuação profissional.						
30	Eu me esforço para criar um ambiente que estimule a expressão de vulnerabilidades e o autoconhecimento raciais.						
31	Minha atuação profissional/clínica não permite participação em celebrações culturais de meus clientes. (Ex.: casamento, formatura, etc).						
32	Considero-me preparado para atuar de forma competente com clientes de grupos étnico-raciais minorizados.						
33	Discuto abertamente com colegas os desafios que enfrento no desenvolvimento da consciência multicultural.						
34	Sigo aprendendo sobre diferentes culturas étnicas através de métodos educacionais e/ou experiências de vida.						
35	É difícil para mim aceitar que religiões possam afetar a						

	forma como minorias étnicas enfrentam doenças e deficiências. (Ex.: Testemunhas de Jeová podem recusar transfusões de sangue)						
--	---	--	--	--	--	--	--

ANEXO F - ESCALA DE EFICÁCIA ANTIRRACISTA

Indique a partir da escala abaixo o quanto você concorda com cada uma das seguintes afirmações.

1. discordo fortemente
2. discordo parcialmente
3. concordo parcialmente
4. concordo fortemente

1. Pessoas como você podem influenciar na maneira que o racismo afeta os outros.	
2. Você se considera bem qualificado para participar em movimentos sociais relacionados ao racismo.	
3. Você compreende as questões importantes enfrentadas pelo nosso país em relação ao racismo.	
4. Pessoas como você não tem nada para dizer sobre o racismo.	

ANEXO G – ESCALA DE CONSCIÊNCIA CRÍTICA (ECC-36)

Escala de Consciência Crítica (ECC-36)

Instrução: Neste questionário não há respostas certas ou erradas, mas é importante você marcar com sinceridade como você se sente com relação a cada uma das afirmativas. Para cada frase, por favor, marque um número para indicar seu grau de concordância.

1. Discordo totalmente
2. Discordo em partes
3. Nem concordo nem discordo
4. Concordo em partes
5. Concordo totalmente

Itens	
1. Me sinto confiante para promover a igualdade de gênero.	
2. Pessoas pobres têm as mesmas oportunidades educacionais que as mais ricas.	
3. Mulheres encontram mais barreiras para se desenvolverem social e economicamente.	
4. Eu posso apoiar a comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero).	
5. Me sinto confiante para promover a igualdade social.	
6. Independente do gênero, as pessoas têm oportunidades iguais em nossa sociedade.	
7. É preciso combater a desigualdade de gênero.	
8. Posso oferecer contribuições para a promoção da igualdade de gênero.	
9. Sou incapaz de promover a igualdade de gênero.	
10. Pessoas negras são discriminadas na sociedade.	
11. Me sinto confiante para lutar contra injustiças econômicas e sociais.	
12. Pessoas negras têm menos oportunidades de desenvolvimento educacional.	
13. Me sinto confiante para defender uma pessoa vítima de racismo.	

14. A classe social é um importante determinante do acesso aos direitos sociais e econômicos.	
15. Posso contribuir para o combate ao racismo.	
16. Pessoas pobres têm menos acesso aos direitos comuns à sociedade (educação, saúde, por ex.).	
17. Não posso fazer nada para promover igualdade social.	
18. É preciso combater a homofobia na sociedade.	
19. Me sinto confiante para combater a homofobia.	
20. Pessoas LGBT são discriminadas na sociedade.	
21. Me sinto incapaz de combater o racismo.	
22. Tenho motivação para participar de ações em apoio à comunidade LGBT.	
23. É preciso combater o racismo na sociedade.	
24. Pessoas LGBT enfrentam mais obstáculos para crescerem profissionalmente.	

Instrução: Neste questionário não há respostas certas ou erradas, mas é importante você marcar com sinceridade como você se sente com relação a cada uma das afirmativas. Para cada frase, por favor, marque o número que indique a frequência na qual tenha realizado as atividades abaixo.

1. Nunca fiz isso
2. Uma ou duas vezes no último ano
3. Uma ou duas vezes nos últimos meses
4. Pelo menos uma vez por mês
5. Pelo menos uma vez por semana

Itens	
25. Participo de ações antirracistas.	
26. Participo de atividades que promovem a igualdade social.	
27. Promovo igualdade racial em minha comunidade.	
28. Uso peças de roupas ou artigos em apoio ao movimento antirracista.	
29. Publico conteúdos nas mídias sociais em apoio à igualdade social.	
30. Confronto as pessoas que usam xingamentos homofóbicos.	
31. Defendo as mulheres impedidas de acessarem seus direitos sociais.	
32. Uso peças de roupas ou artigos em apoio à comunidade LGBT.	
33. Falo para as pessoas não usarem xingamentos racistas.	
34. Defendo as pessoas que sofrem homofobia.	
35. Participo de movimentos de apoio à igualdade de gênero.	
36. Luto pelos direitos das mulheres.	

ANEXO H – INSTRUMENTO ORIGINAL

Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI)

Fabricio Balcazar, Ph.D., Yolanda Suarez-Balcazar, Ph.D., Tina Taylor-Ritzler, Ph.D.,
Juleen Rodakowski, OTD, Celestine Willis, M.Ed., and Nelson Portillo, Ph.D.
University of Illinois at Chicago

This work was funded by the National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR), U.S. Department of Education, through a grant to the Center for Capacity Building on Minorities with Disabilities Research at the University of Illinois at Chicago (Grant # H133A040007). The opinions expressed herein are those of the authors and not necessarily those of NIDRR.

Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI)

PART 1: ABOUT YOU.

Please circle the numbers or complete the correct response(s) to the following questions.

1. **Are you:** (1) Female (2) Male
2. **How old are you?** _____ Years
3. **What is your race/ethnicity? (Select ALL applicable):**

(1) African American/Black	(5) Hispanic/Latino(a)
(2) Asian	(6) White
(3) Hawaiian/Pacific Islander	(7) Other. <i>Please specify</i> _____
(4) American Indian/Alaskan Native	
4. **Do you speak any language(s) other than English when providing services?** (1) Yes (2) No
5. **If Yes, what are these languages?** _____
6. **What is the highest level of education you have obtained?**

(1) Less than high school	(5) Bachelor's degree
(2) High school graduate/ GED	(6) Master's degree (MA, MS)
(3) Some college, no degree	(7) Professional Degree (MD, JD, PTD, OTD, PsyD)
(4) Associate degree	(8) Doctorate Degree (Ph.D./ Ed.D)
7. **What is your current position?**

(1) Executive Director (e.g., CEO)	(5) Professional (e.g., MD, LCSW, Physical Therapists, Rehab & Mental Health counselors, Ph.D.)
(2) Volunteer	
(3) Administrative (e.g., receptionist)	(6) Managerial (e.g., project director, supervisor)
(4) Service worker (e.g., job training specialist)	(7) Other. <i>Please specify</i> _____
8. **How many years have you been working in your current position?** _____ Years
9. **Which of the following types of training did you receive on cultural competency, if any?**
Circle ALL the responses that apply.
 - (1) I took a required class that focused SPECIFICALLY on this topic in school
 - (1) I took an elective class that focused SPECIFICALLY on this topic in school
 - (2) This topic was covered in various classes in school
 - (3) I learned about this during my fieldwork experience in school
 - (4) I took continuing education (CE) workshops or CE courses on this topic
 - (5) I gained knowledge from reading about this topic on my own
 - (6) I learned about it through supervision on the job
 - (7) I learned about it through interaction with professionals from other disciplines at my workplace
 - (8) I have had no formal training on cultural competency

PART 2: ABOUT YOUR WORK during the PAST YEAR ONLY.

Please circle the number(s) or complete the correct response(s) to the following questions:

10. Indicate the top 3 populations that you see most often in your work:

- (1) African American/Black (5) Hispanic/Latino(a)
 (2) Asian (6) White
 (3) Hawaiian/Pacific Islander (7) Other. *Please specify* _____
 (4) American Indian/Alaskan Native

11. Rate your level of success in outreaching the following ethnic populations:

	Very Successful					Very Unsuccessful	N/A
African American/Black	6	5	4	3	2	1	0
Asian	6	5	4	3	2	1	0
Hawaiian/Pacific Islander	6	5	4	3	2	1	0
Native American/Alaskan Native	6	5	4	3	2	1	0
Hispanic/Latino(a)	6	5	4	3	2	1	0
White	6	5	4	3	2	1	0
Other (<i>Please specify</i>)	6	5	4	3	2	1	0

12. Rate your level of success in retaining the following ethnic populations:

	Very Successful					Very Unsuccessful	N/A
African American/Black	6	5	4	3	2	1	0
Asian	6	5	4	3	2	1	0
Hawaiian/Pacific Islander	6	5	4	3	2	1	0
Native American/Alaskan Native	6	5	4	3	2	1	0
Hispanic/Latino(a)	6	5	4	3	2	1	0
White	6	5	4	3	2	1	0
Other (<i>Please specify</i>)	6	5	4	3	2	1	0

CONSIDERING YOUR WORK OVER THE <u>PAST YEAR</u>		Strongly Agree					Strongly Disagree
13.	I feel that I can learn from my ethnic minority clients.	6	5	4	3	2	1
14.	It is hard adjusting my therapeutic strategies with ethnic minority clients.	6	5	4	3	2	1
15.	I am effective in my verbal communication with clients whose culture is different from mine.	6	5	4	3	2	1
16.	My organization does not provide ongoing training on cultural competence.	6	5	4	3	2	1
17.	I do not consider the cultural backgrounds of my clients when food is involved.	6	5	4	3	2	1
18.	I receive feedback from supervisors on how to improve my practice skills with clients from different ethnic minority backgrounds.	6	5	4	3	2	1
19.	At work, pictures, posters, printed materials and toys reflect the culture and ethnic backgrounds of ethnic minority clients.	6	5	4	3	2	1
20.	I feel confident that I can learn about my clients' cultural background.	6	5	4	3	2	1
21.	Cultural competence is included in my work place's mission statement, policies, and procedures.	6	5	4	3	2	1
22.	I am effective in my nonverbal communication with clients whose culture is different from mine.	6	5	4	3	2	1
23.	The way services are structured in my setting makes it difficult to identify the cultural values of my clients.	6	5	4	3	2	1
24.	I feel that I have limited experience working with ethnic minority clients.	6	5	4	3	2	1
25.	It is difficult to practice skills related to cultural competence.	6	5	4	3	2	1
26.	I am sensitive to valuing and respecting differences between my cultural background and my clients' cultural heritage.	6	5	4	3	2	1
27.	My workplace does not support using resources to promote cultural competence.	6	5	4	3	2	1
28.	I have opportunities to learn culturally responsive behaviors from peers.	6	5	4	3	2	1
29.	I do not feel that I have the skills to provide services to ethnic minority clients.	6	5	4	3	2	1
30.	I examine my own biases related to race and culture that may influence my behavior as a service provider.	6	5	4	3	2	1
31.	I actively strive for an atmosphere that promotes risk-taking and self-exploration.	6	5	4	3	2	1
32.	My work place does not support my participation in cultural celebrations of my clients.	6	5	4	3	2	1
33.	I would find it easy to work competently with ethnic minority clients.	6	5	4	3	2	1
34.	I openly discuss with others issues I may have in developing multicultural awareness.	6	5	4	3	2	1
35.	I learn about different ethnic cultures through educational methods and/or life experiences.	6	5	4	3	2	1
36.	It is difficult for me to accept that religious beliefs may influence how ethnic minorities respond to illness and disability.	6	5	4	3	2	1